

BEOS-260/25

Warszawa, 7 lipca 2025 r.

WYDZIAŁ OBSŁUGI PREZYDIUM SEJMU

L.dz. 88-III.00.33.51.225

Data wpływu 07.07.2025

Pan

Szymon Hołownia

Marszałek Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej

**Opinia w sprawie oceny skutków regulacji poselskiego projektu ustawy
o zawodzie psychoterapeuty oraz samorządzie zawodowym
(druk sejmowy nr 1345)**

Na podstawie art. 34 ust. 9a uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r.
– Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2022 r. poz. 990, ze zm.)
sporządza się następującą opinię:

I. Problem, który zamierzają rozwiązać Wnioskodawcy

Wnioskodawcy wskazują, że zawód psychoterapeuty wykonuje ponad 22 tys. osób. Z psychoterapii korzystają setki tysięcy osób. Zapotrzebowanie wielokrotnie przekracza aktualną liczbę aktywnych specjalistów. Jeden psychoterapeuta przypada na 25 tys. osób. Praca psychoterapeutów jest niezwykle ważna, gdyż zgodnie z raportami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) choroby psychiczne to jedno z największych wyzwań XXI wieku. Zawód psychoterapeuty ma istotną rolę w systemie ochrony zdrowia psychicznego – oprócz farmakoterapii jest to główna metoda leczenia zaburzeń psychicznych oraz podstawowa metoda postępowania w przypadku profilaktyki występowania zaburzeń psychicznych oraz dbania o jakość zdrowia psychicznego, zgodnie z definicją zdrowia psychicznego według WHO, która uznaje, iż zdrowie psychiczne to znacznie więcej niż brak występowania choroby. Psychoterapia jest obszarem szczególnie wrażliwym społecznie, ponieważ dotyczy kwestii zdrowia i równowagi psychicznej oraz wiąże się z dostępem do poufnych, osobistych, intymnych danych, przy czym dobro interesu publicznego predestynuje ten zawód do grona zawodów zaufania publicznego.

Mimo tak znaczącej roli w systemie, zawód psychoterapeuty nie jest obecnie uregulowany w sposób kompleksowy w polskim porządku prawnym. Obowiązują szczątkowe regulacje zawarte w:

• rozporządzeniach „koszykowych” dla świadczeń wykonywanych w ramach NFZ¹;

• rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień², które w § 2 pkt 5 zawiera definicję osoby posiadającej certyfikat psychoterapeuty;

• art. 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, zawierającym definicję psychoterapii wykonywanej w podmiotach leczniczych.

W ocenie Wnioskodawców regulacje te są niewystarczające i ograniczyły się do utrwalenia stanu „niedoregulowania” statusu zawodu psychoterapeuty. Wprowadziły jedynie na poziom ustawowy regulacje w zakresie określania osób uprawnionych do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu psychoterapii finansowanych ze środków publicznych. Świadczenie psychoterapii na rynku usług prywatnych jest nieuregulowane, co rodzi wiele zagrożeń dla osób korzystających z tej formy wsparcia. Brak jednolitych przepisów określających wymagania kwalifikacyjne, zasady etyki zawodowej oraz mechanizmy odpowiedzialności zawodowej powoduje, że osoby nieposiadające odpowiednich kompetencji mogą oferować usługi psychoterapeutyczne. Skutkuje to niepewnością prawną zarówno dla pacjentów, jak i dla samych psychoterapeutów. Osoby korzystające z usług psychoterapeutycznych nie mają gwarancji, że świadczone im usługi będą wykonywane przez osobę posiadającą odpowiednie przygotowanie teoretyczne i praktyczne. Brak nadzoru nad wykonywaniem tego zawodu rodzi ryzyko występowania nieprawidłowości, takich jak nadużycia wobec pacjentów, naruszenia etyki zawodowej lub wykonywanie psychoterapii przez osoby bez odpowiedniego przeszkolenia. Bez samorządu zawodowego złożonego z psychoterapeutów merytoryczna piecza nad wykonywaniem zawodu nie jest możliwa.

Zawód psychoterapeuty nie jest objęty prawną ochroną tytułu zawodowego, co oznacza, że każdy może się nim posługiwać, niezależnie od posiadanego wykształcenia czy doświadczenia.

Brak jednolitych przepisów powoduje również trudności w uznawaniu kwalifikacji osób, które ukończyły studia lub szkolenia za granicą. Powoduje to problemy z dostępem do zawodu dla osób z innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

II. Rozwiązanie rekomendowane przez Wnioskodawców

Rozwiązanie problemów zidentyfikowanych przez Wnioskodawców ma zostać osiągnięte przez przyjęcie kompleksowej ustawy o zawodzie psychoterapeuty oraz samorządzie zawodowym. Projektowana ustawa przyznaje psychoterapeutom status zawodu zaufania publicznego oraz ustanawia samorząd zawodowy psychoterapeutów. Projektowana ustawa ma określić zasady wykonywania zawodu psychoterapeuty oraz zapewnić skuteczny nadzór nad osobami go wykonującymi, zarówno w podmiotach leczniczych, jak i na rynku prywatnym. Wprowadzenie

¹ Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych, wydawane na podstawie art. 31d ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2024 r. poz. 917).

² Dz. U. poz. 1285, ze zm.

ustawy, zdaniem Wnioskodawców, umożliwi stworzenie spójnego systemu regulacyjnego, który obejmie zasady szkolenia i uzyskiwania prawa do wykonywania zawodu, rejestrację psychoterapeutów, podmiotów szkolących i egzaminujących, pieczę nad wykonywaniem zawodu oraz zasady odpowiedzialności zawodowej psychoterapeutów.

Projektowana ustawa reguluje m.in. następujące kwestie:

- uznanie zawodu psychoterapeuty za zawód zaufania publicznego;
- ochronę prawną tytułu „psychoterapeutka” i „psychoterapeuta”;
- definicję wykonywania zawodu psychoterapeuty;
- formy wykonywania zawodu;
- zasady wykonywania zawodu psychoterapeuty, w tym zasady wpisu do Rejestru Psychoterapeutów, warunki, które musi spełniać osoba, by być wpisaną do Rejestru Psychoterapeutów, dane wpisywane do Rejestru Psychoterapeutów, sposoby wykonywania czynności zawodowych;
- przetwarzanie danych osobowych;
- szkolenie psychoterapeutów aplikantów i psychoterapeutów, w tym Rejestr Podmiotów Szkolących i zasady wpisu do tego rejestru, Rejestr Ośrodków Egzaminacyjnych, przeprowadzanie i zakres egzaminu certyfikującego (będącego podstawą do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty, który jest jednym z warunków wpisu do Rejestru Psychoterapeutów);
- samorząd zawodowy psychoterapeutów, w tym jego zadania i organizację, a także majątek i gospodarkę finansową;
- odpowiedzialność dyscyplinarną psychoterapeutów i psychoterapeutów aplikantów, w tym postępowanie dyscyplinarne i postępowanie mediacyjne;
- przesłanki zawieszenia prawa do wykonywania zawodu psychoterapeuty i psychoterapeuty aplikanta, przesłanki skreślenia z Rejestru Psychoterapeutów lub Rejestru Psychoterapeutów Aplikantów;
- przepisy karne i kary pieniężne;
- przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe.

Projektowana ustawa ma wejść w życie w terminie 1 roku od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 44, dotyczącego ośrodków stażowych, w których psychoterapeuta aplikant ma odbywać staż. Przepis ten ma wejść w życie po upływie 10 lat od opublikowania ustawy.

III. Inne rozwiązania rozważane przez Wnioskodawców

Wnioskodawcy wskazują, że rozważali inne rozwiązania.

Pierwszym alternatywnym rozwiązaniem jest pozostawienie zawodu psychoterapeuty jako zawodu wolnego, tj. bez regulacji ustawowej. Zawód ten mógłby funkcjonować na zasadach wolnego rynku, tak jak niektóre inne usługi doradcze czy szkoleniowe. Rozwiązanie to zostało przez Wnioskodawców odrzucone ze względu na negatywne skutki, występujące szczególnie na rynku prywatnym, ale nie tylko, tj.:

- brak ochrony tytułu "psychoterapeuta" – każda osoba, niezależnie od wykształcenia i braku przygotowania może używać tego tytułu, co stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów;
- brak nadzoru nad procesem szkolenia i certyfikowania psychoterapeutów poza uznanymi stowarzyszeniami psychoterapeutów;
- brak systemu nadzoru nad zawodem – nie ma organu nadzorczego, który mógłby reagować na zgłoszenia o naruszeniach etyki zawodowej. Pacjenci nie mogą składać skarg na psychoterapeutów;
- brak systemu odpowiedzialności zawodowej – osoby wykonujące zawód psychoterapeuty nie ponoszą odpowiedzialności zawodowej, a droga sądowa jest mało dostępna dla poszkodowanych. Stowarzyszenia nie mają możliwości odbierania prawa do wykonywania zawodu;
- ryzyko dla zdrowia publicznego – pacjenci korzystają często z usług osób bez kwalifikacji, nie mając możliwości zweryfikowania osoby, z której usług korzystają. Może to prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, szczególnie w przypadku leczenia zaburzeń psychicznych.

Drugim alternatywnym rozwiązaniem jest regulacja ustawowa bez samorządu zawodowego, z samym rejestrem i odpowiedzialnością zawodową. Propozycja została przez Wnioskodawców odrzucona, gdyż:

- nie chroni w pełni psychoterapeutów – brak ochrony tajemnicy zawodowej na poziomie zawodów zaufania publicznego (por. art. 180 § 2 Kodeksu postępowania karnego³);
- taka regulacja pozostawia znaczące luki w postaci braku regulacji szkolenia w psychoterapii, co utrzymuje niekorzystny stan prawny tj. powstawanie kursów o niskiej jakości bez szczegółowych wymagań dotyczących kadry szkolącej oraz programu szkolenia;
- nie przewiduje organu zdolnego do trzymania pieczy nad jakością szkolenia i standardami zawodowymi oraz pieczy nad wykonywaniem zawodu;
- nie przewiduje organu reprezentującego interesy przedstawicieli zawodu psychoterapeuty.

IV. Rozwiązania przyjmowane w innych państwach, w szczególności państwach członkowskich OECD/UE

W Europie, Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii (EAP) odgrywa kluczową rolę w wysiłkach na rzecz ustanowienia psychoterapii jako autonomicznego zawodu. W swoim „Oświadczeniu w sprawie sytuacji prawnej psychoterapii w Europie”⁴ EAP dokonało analizy uregulowań prawnych psychoterapii w różnych krajach europejskich, podkreślając ich duże zróżnicowanie. Na podstawie tej analizy można wyróżnić trzy kategorie państw pod względem regulacji dotyczących zawodu psychoterapeuty.

³ Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 46).

⁴ *EAP Statement on the Legal Position of Psychotherapy in Europe*, styczeń 2021 r., <https://www.europsyche.org/portals/0/media/docs/Legal-Position-of-Psychotherapy-in-Europe-2021-Final.pdf>. [wszystkie źródła internetowe cytowane w niniejszej opinii zostały sprawdzone 7 VII 2025 r.].

Do pierwszej kategorii można zaliczyć państwa, które przyjęły regulacje dotyczące zawodu psychoterapeuty jako niezależnego, odrębnego zawodu.

W Austrii ustawa o psychoterapii z 2024 r.⁵ wprowadza kompleksowe regulacje dotyczące zawodu psychoterapeuty (*Psychotherapeut*) oraz uznawania kwalifikacji uzyskanych w innych państwach, określając trzystopniowy system edukacji: studia licencjackie (*Bachelorstudium der Psychotherapie*), studia magisterskie (*Masterstudium der Psychotherapie*), podyplomowe szkolenie psychoterapeutyczne (*postgraduale psychotherapeutische Fachausbildung*). Po ukończeniu szkolenia psychoterapeuci muszą zdać Psychoterapeutyczny Egzamin Aprobacyjny (*Psychotherapeutische Approbationsprüfung*), który jest warunkiem uzyskania prawa do wykonywania zawodu. Następnie konieczny jest wpis do Oficjalnej Listy Zawodowej Psychoterapeutów (*Berufsliste Psychotherapie*), co umożliwia legalne świadczenie usług terapeutycznych w Austrii. Przynależność do izby zawodowej nie jest obowiązkowa, jednak psychoterapeuci mogą dobrowolnie dołączyć do organizacji branżowych (*Berufsverbände*), które wspierają rozwój zawodowy i organizują szkolenia.

W Chorwacji zawód psychoterapeuty jest regulowany przez ustawę o działalności psychoterapii⁶. Aby uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu psychoterapeuty, kandydat musi posiadać dyplom studiów licencjackich i magisterskich lub zintegrowanych studiów magisterskich w dziedzinach takich jak: medycyna, psychologia, praca socjalna, rehabilitacja edukacyjna, pedagogika specjalna, pedagogika czy logopedia, uzyskanych w Chorwacji, innym kraju Unii Europejskiej lub w państwie trzecim, pod warunkiem uznania kwalifikacji zagranicznych w Chorwacji. Wymagane jest ukończenie co najmniej czteroletniego szkolenia w określonym nurcie psychoterapeutycznym, uznawanym przez EAP i zatwierdzonym przez odpowiednią międzynarodową organizację dla danego nurtu. Po spełnieniu wymienionych wymagań edukacyjnych, kandydat musi złożyć wniosek o członkostwo w Chorwackiej Izbie Psychoterapeutów, która prowadzi rejestr psychoterapeutów oraz wydaje pozwolenia na samodzielne wykonywanie zawodu. Dopiero po uzyskaniu licencji możliwe jest legalne świadczenie usług psychoterapeutycznych. Członkostwo w Chorwackiej Izbie Psychoterapeutów jest obowiązkowe dla wszystkich praktykujących psychoterapeutów. Izba ta odpowiada za prowadzenie rejestru psychoterapeutów, nadzór nad przestrzeganiem standardów zawodowych oraz etyki zawodowej, a także za zapewnienie ciągłego doskonalenia zawodowego swoich członków.

Na Malcie zawód psychoterapeuty jest regulowany na mocy ustawy o zawodzie psychoterapeuty⁷. Ustawa określa wymagania dotyczące wykształcenia, procedur uzyskania tytułu, obowiązkowej rejestracji oraz nadzoru nad wykonywaniem zawodu. Psychoterapia jest uznawana za zawód regulowany, co

⁵ *Psychotherapiegesetz 2024* (PThG 2024), tekst w j. niemieckim:

<https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20012578&Artikel=&Paragraf=0&Anlage=&Uebergangsrecht=>

⁶ *Zakon o djelatnosti psihoterapije*, tekst w j. chorwackim: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_07_64_1307.html.

⁷ *Psychotherapy Profession Act*, Rozdział 587, tekst w j. angielskim: <https://legislation.mt/eli/cap/587/eng/pdf>.

oznacza, że tylko osoby spełniające określone kryteria mogą legalnie świadczyć usługi psychoterapeutyczne. Chcąc uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu psychoterapeuty, kandydat musi spełnić określone wymagania edukacyjne i proceduralne. Przede wszystkim konieczne jest ukończenie studiów licencjackich na uczelni wyższej uznawanej przez maltańskie władze edukacyjne w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych. Następnie wymagane jest ukończenie specjalistycznego szkolenia w określonej modalności psychoterapeutycznej, które musi obejmować minimum 3 000 godzin kształcenia lub równoważne 120 punktów ECTS, co odpowiada poziomowi magisterskiemu. Po spełnieniu formalnych wymagań edukacyjnych kandydat musi złożyć wniosek do Rady ds. Zawodu Psychoterapeuty (*Psychotherapy Profession Board*), która dokonuje oceny kwalifikacji i wydaje decyzję o nadaniu uprawnień do wykonywania zawodu. Po uzyskaniu zgody, psychoterapeuta jest zobowiązany do rejestracji w oficjalnym rejestrze psychoterapeutów, który jest prowadzony przez Radę. Wpis do rejestru jest warunkiem koniecznym do legalnego prowadzenia praktyki. Przynależność do Rady ds. Zawodu Psychoterapeuty jest obowiązkowa dla wszystkich praktykujących psychoterapeutów. Organ ten odpowiada za wydawanie uprawnień, prowadzenie rejestru zawodowego oraz nadzór nad przestrzeganiem standardów etycznych i zawodowych. Psychoterapeuci podlegają przepisom dotyczącym ustawicznego kształcenia oraz etyki zawodowej, co zapewnia wysoką jakość świadczonych usług.

W Niemczech zawód psychoterapeuty jest regulowany przez ustawę o zawodzie psychoterapeuty⁸, która określa wymagania edukacyjne, procedury uzyskania tytułu oraz kwestie związane z członkostwem w izbach zawodowych i rejestrach oraz uznawania kwalifikacji uzyskanych w innych państwach. Zgodnie z §5 ustawy, aby uzyskać aprobatę (*Approbation*) i prawo do wykonywania zawodu psychoterapeuty, konieczne jest ukończenie pięcioletnich studiów wyższych na poziomie magisterskim w dziedzinie psychoterapii oraz zdanie państwowego egzaminu psychoterapeutycznego (*staatliche psychotherapeutische Prüfung*). Po uzyskaniu aprobaty, psychoterapeuci odbywają kilkuletnią specjalistyczną praktykę zawodową (*Weiterbildung*), pracując pod nadzorem w akredytowanych placówkach medycznych, analogicznie do specjalizacji lekarskiej. Po zakończeniu tej praktyki i zdaniu odpowiedniego egzaminu, psychoterapeuci mogą ubiegać się o wpis do rejestru (*Arztregister*), co umożliwia im samodzielne świadczenie usług w ramach systemu opieki zdrowotnej. Zawód psychoterapeuty jest w Niemczech zawodem regulowanym, jego wykonywanie jest ściśle określone przez przepisy prawne, a używanie tytułu zawodowego jest chronione prawnie. Psychoterapeuci są zobowiązani do członkostwa w odpowiednich izbach zawodowych (*Psychotherapeutenkammern*) na poziomie landów, które to izby pełnią funkcje nadzorcze, dbają o przestrzeganie standardów zawodowych oraz organizują obowiązkowe szkolenia ustawiczne (*Fortbildungen*).

Do drugiej kategorii, zgodnie z analizą EAP, można zaliczyć państwa, w których nawet jeśli istnieją odrębne regulacje dotyczące zawodu psychoterapeuty, to możliwość wykonywania zawodu została ograniczona do osób posiadających

⁸ *Psychotherapeutengesetz*, (PsychThG), tekst w j. niemieckim: https://www.gesetze-im-internet.de/psychthg_2020/.

wykształcenie medyczne lub psychologiczne. W Luksemburgu w 2015 r. uchwalono ustawę o psychoterapii⁹, zgodnie z którą wszyscy psychoterapeuci muszą posiadać tytuł magistra psychologii lub psychoterapii lub równoważny certyfikat szkolenia medycznego. Na Węgrzech psychoterapia jest zdefiniowana w ustawie o zdrowiu CLIV z 1997 r.¹⁰ i może być praktykowana wyłącznie przez wyspecjalizowanego lekarza lub psychologa klinicznego posiadającego kwalifikacje w zakresie psychoterapii. We Włoszech psychoterapia może być praktykowana wyłącznie po ukończeniu 4-letniego szkolenia podyplomowego, do którego można przystąpić wyłącznie z dyplomem lekarza lub psychologa. W Szwajcarii od psychoterapeutów wymagany jest tytuł magistra psychologii i 4 letnie studia podyplomowe. Wykształcenie psychologiczne wymagane jest również np. w Rumunii i Szwecji. W Danii lekarze i psychologowie mogą być szkoleni w zakresie psychoterapii w ramach swojej edukacji i stosować psychoterapię w swojej pracy z pacjentami. We Francji od 2010 r. tytuł psychoterapeuty mogą uzyskać osoby wpisane do rejestru lekarzy, psychologów i/lub psychoanalityków. W Holandii tylko psychologowie, psychiatrzy i lekarze mogą rozpocząć szkolenie w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej, a następnie wpisać się do krajowego rejestru. W Finlandii zawód psychoterapeuty jest regulowany prawnie i objęty ochroną tytułu zawodowego zgodnie z rozporządzeniem w sprawie pracowników służby zdrowia¹¹. Tytułem zawodowego psychoterapeuty może posługiwać się osoba, która ukończyła szkolenie jako psychoterapeuta na uniwersytecie w rozumieniu ustawy o uniwersytetach lub na uniwersytecie wraz z inną organizacją szkoleniową, przy czym uczelnia organizująca szkolenie musi być odpowiedzialna za kształcenie w dziedzinie psychologii lub medycyny.

Do trzeciej kategorii należą państwa, w których zawód psychoterapeuty nie jest uregulowany i tytuł psychoterapeuty nie jest prawnie chroniony. (np. Albania, Cypr, Grecja, Litwa, Portugalia, Serbia). W państwach z powyższej kategorii osoby wykonujące zawody związane z psychoterapią dokonują samoregulacji w ramach organizacji zawodowych (Bułgaria, Irlandia) lub w formie prowadzenia dobrowolnych rejestrów (Wielka Brytania). EAP podkreśla jednak, że szereg z tych państw prowadzi działania na rzecz regulacji zawodu psychoterapeuty.

V. Skutki prawne projektowanej ustawy

Wniesiony przez Wnioskodawców projekt stanowi kompleksowe uregulowanie nowego samorządu zawodowego. Ze względu na rozmiar omawianej regulacji nie jest celem niniejszej oceny skutków prawnych projektu kompleksowe przedstawienie czy skomentowanie wszystkich projektowanych przepisów, a zwrócenie uwagi na ich zasadnicze aspekty oraz istotne wątpliwości.

⁹ *Loi modifiée du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute*, tekst w j. francuskim: <https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2015/07/14/n1/lo>.

¹⁰ 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről, tekst w j. węgierskim: <https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700154.tv>.

¹¹ *Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä*, tekst w j. fińskim: https://finlex.fi/fi/lainsaadanto/1994/564#sec_2av20101120_heading.

Postawę dla tworzenia samorządów zawodowych ustanawia art. 17 Konstytucji. Przepis ten powinien być rozumiany w kontekście innych uregulowań, w szczególności artykułów 20 i 22. Artykuł 20 Konstytucji ustanawia wolność działalności gospodarczej (w ramach społecznej gospodarki rynkowej), a art. 22 Konstytucji stanowi, że: „Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny.” W literaturze obecny jest także pogląd, że zawody zaufania publicznego stanowią wyraz realizowania konstytucyjnej zasady decentralizacji¹² (wyrażonej w art. 15 Konstytucji). W literaturze prawniczej wskazuje się, że „zawód zaufania publicznego polega na zaspokajaniu istotnych osobistych potrzeb ludzkich, z czym wiąże się przetwarzanie informacji dotyczących życia osobistego”¹³. Zawód psychoterapeuty z pewnością spełnia te przesłanki, m.in. z tego względu od lat toczyły się dyskusje dotyczące uregulowania tej profesji¹⁴. Potrzeba zapewnienia zdrowia czy też poprawy stanu psychicznego (czy w szerszym, filozoficznym sensie: dążenie do szczęścia) stanowi jedną z najważniejszych życiowych potrzeb, spełnianą przez ludzi na różne sposoby, w tym także poprzez korzystanie z usług i świadczeń psychoterapeutycznych. Co istotne psychoterapeuci mają dostęp do informacji dotyczących intymnych aspektów życia swoich pacjentów, porównywalnych, a nieraz znacznie bardziej prywatnych niż przedstawiciele już istniejących zawodów zaufania publicznego¹⁵. Utworzenie samorządu zawodowego psychoterapeutów jest zatem uzasadnione ze względu na dobro osób korzystających z psychoterapii.

Na gruncie obowiązujących przepisów nie ma wątpliwości, że utworzenie samorządu zawodowego oraz zawodu zaufania publicznego jest uzasadnione i w ogólności nie jest niezgodne z Konstytucją. Wątpliwości budzą natomiast szczegółowe przepisy projektowanej ustawy.

Artykuł 2 projektu zawiera rozbudowaną definicję zawodu psychoterapeuty, podzieloną na ust. 1, który definiuje na czym polega wykonywanie zawodu psychoterapeuty oraz ust. 2 stanowiący, że „wykonywanie zawodu psychoterapeuty odbywa się poprzez prowadzenie psychoterapii” opartej na jednym z pięciu podejść przyjętych w ustawie. Ust. 1 powierzchownie przypomina art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego¹⁶, choć zawiera istotne różnice.

¹² Por. J. Smarż, *Samorząd zawodowy jako wyraz decentralizacji władzy publicznej*, „Samorząd Terytorialny” 2021, nr 1-2, s. 62-74.

¹³ P. Tuleja [w:] P. Czarny, M. Florczak-Wątor, B. Naleziński, P. Radziejewicz, P. Tuleja, *Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz*, Warszawa 2023, komentarz do art. 17. <http://10.10.74.7/#/commentary/587806611/736714/tuleja-piotr-red-konstytucja-rzeczypospolitej-polskiej-komentarz-wyd-ii?cm=URELATIONS>.

¹⁴ I. Korczak-Kubalski, *Samorząd zawodowy psychologów w Polsce – uregulowania prawne i perspektywy*, „Przegląd Prawa Publicznego” 2022, nr 7-8, s. 224-238; L. J. Żukowski, *Psycholog jako zawód zaufania publicznego – wybrane problemy*, „Przegląd Prawa Publicznego” 2017, nr 3, s. 39-49.

¹⁵ Choroby i zaburzenia psychiczne wiążą się z istotnym poczuciem wstydu. Niektóre informacje objęte tajemnicą zawodową np. lekarską czy adwokacką nie wiążą się z tak silnie przeżywanym wstydem (np. złamana noga czy popełnienie drobnego wykroczenia).

¹⁶ Dz. U. z 2024 r. poz. 917, Art. 5 ust. 2: „Psychoterapia to celowe i planowane oddziaływania psychologiczne, zmierzające do złagodzenia lub usunięcia objawów zaburzenia oraz do poprawy funkcjonowania psychicznego i społecznego, wspierające dążenia jednostki lub rodziny do zdrowia i rozwoju, kierowane do osób z zaburzeniami psychicznymi.”

Niezależnie od powyższych uwag, zawarta w art. 2 ust. 1 projektu definicja jest wadliwa, a to ze względu na jej tautologiczny charakter. Zgodnie z brzmieniem projektowanego przepisu:

„Art. 2

1. Wykonywanie zawodu psychoterapeuty polega na (...) oddziaływaniu (...) polegającym na:

- 1) prowadzeniu konsultacji psychoterapeutycznych,
- 2) diagnozie psychoterapeutycznej,
- 3) kwalifikacji do odpowiedniej formy psychoterapii,
- 3) prowadzeniu psychoterapii”.

Ust. 2 pogłębia jeszcze błędne koło w formułowaniu definicji zawodu psychoterapeuty, bez jasnego zdefiniowania psychoterapii (lub odesłania do wspomnianej wyżej ustawy o ochronie zdrowia psychicznego). Prawidłowa definicja psychoterapii ma kluczowe znaczenie dla kolejnych przepisów projektowanej regulacji. Przykładowo, art. 44 ust. 1 projektu stanowi, że „Ośrodek stażowy, w którym psychoterapeuta aplikant odbywa staż, musi spełnić następujące kryteria: 1) ośrodek powinien prowadzić psychoterapię od 3 lat”¹⁷.

Konsekwencją utworzenia zawodu zaufania publicznego jest zastrzeżenie możliwości dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonego rodzaju działalności przez osoby będące przedstawicielami danego zawodu. W warunkach (społecznej) gospodarki rynkowej powierzenie wykonywania zawodu zaufania publicznego osobom spełniającym określone warunki będzie wiązać się z ograniczeniem bądź nawet zakazem prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby niebędące przedstawicielami tego zawodu. Artykuł 22 Konstytucji stanowi, że „Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny.” Jest to jednoznaczne ograniczenie nie tylko co do sposobu jego ustanowienia, ale także co do jego zakresu. Przesłanka interesu publicznego jest warunkiem koniecznym ograniczenia wolności działalności gospodarczej. Artykuł 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców ¹⁸ stanowi, że: „Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach”. Przepis ten stanowi *lex generalis*, a ograniczenia wynikające z ustaw nadających wyłączne prawo przedstawicielom zawodów zaufania publicznego – *lex specialis* dla tej regulacji, podlegające ocenie co do konstytucyjności wobec przywołanego wyżej art. 22 Konstytucji.

Artykuł 2 ust. 4 projektu znacząco rozszerza katalog czynności, które byłyby uznane za wykonywanie zawodu psychoterapeuty. Wśród nich znajdują się takie, które budzą wątpliwości zarówno co do ich konstytucyjności, jak i ogólnej zasadności – uwaga ta odnosi się do następujących punktów w art. 2 ust. 4 projektu:

- 2) prowadzenie działalności dydaktycznej w zakresie psychoterapii,
- 4) prowadzenie działań edukacyjnych lub profilaktycznych w zakresie zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia psychicznego i psychoterapii;

¹⁷ Na marginesie można zaznaczyć, że sformułowanie tego przepisu jest obarczone wadą – powinno brzmieć: „od co najmniej 3 lat”.

¹⁸ Dz. U. z 2024 r. poz. 236, ze zm.

5) prowadzenie działalności polegającej na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego;

7) pełnienie funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych zajmujących się psychoterapią.

Współczesna edukacja, także psychoterapeutów, jest przedsięwzięciem zasadniczo interdyscyplinarnym. Zasadnym jest zatem umożliwienie zaangażowania w działalność dydaktyczną specjalistów z innych dziedzin¹⁹. Równocześnie, edukacja profilaktyczna i prozdrowotna w obszarze zdrowia psychicznego nie jest działalnością, której charakter uzasadniałby ograniczanie jej prowadzenia do osób będących psychoterapeutami. Przeciwnie, interes publiczny może przemawiać za tym, by dopuścić do wykonywania takich działań szerszy krąg osób o odpowiednich kompetencjach.

Jednostki organizacyjne zajmujące się psychoterapią mogą oferować szeroki zakres usług (przede wszystkim medycznych), zasadne jest zatem, by funkcję kierownicze w nich mogły być sprawowane przez osoby niebędące psychoterapeutami²⁰.

Rozważając zasadność ograniczenia działalności gospodarczej i powierzenia jej wykonywania wyłączenie przedstawicielom jednego zawodu warto mieć na uwadze zakres takiego ograniczenia²¹. Od decyzji ustawodawcy zależy, jak daleko idące ma być takie ograniczenie. Należy jednak pamiętać, że nie powinno ono naruszać art. 22 Konstytucji.

Art. 5 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 3 projektu budzą wątpliwości co do uregulowania sposobu wykonywania usług psychoterapeutycznych. Art. 3 stanowi, że psychoterapeuta wykonuje swój zawód osobiście. Charakter zawodu w pełni uzasadnia takie uregulowanie – kluczowe czynności dokonywane w toku psychoterapii powinny być przeprowadzane przez osobę spełniającą ustawowe kryteria. Jednocześnie w przypadku wejścia ustawy w życie w jej obecnym brzmieniu art. 5 ust. 1 pkt 6 wprowadzałby możliwość wykonywania usług przez psychoterapeutę „w ramach spółek prawa handlowego” (a zatem nie tylko spółek osobowych, ale również spółek kapitałowych). Umożliwienie wykonywania zawodu psychoterapeuty w ramach spółek kapitałowych może budzić wątpliwości co do wewnętrznej spójności projektowanej ustawy (wymóg osobistego wykonywania zawodu uregulowany w art. 3 projektu), jak również zapewnienia prawidłowego wykonywania zawodu psychoterapeuty²². Dodatkowo należy uznać, że zwrot

¹⁹ Np. komunikacji, glottodydaktyki, pedagogiki, psychologii społecznej, socjologii, ale też prawa.

²⁰ W szczególności wobec oferowania przez uczelnie wyższe kierunków takich jak zarządzanie w ochronie zdrowia, czy zarządzanie w sektorze publicznym.

²¹ Dla zobrazowania warto przywołać przykłady stopniowania takich ograniczeń. Na przykład przymus radcowsko-adwokacki obowiązuje w postępowaniu przed Sądem Najwyższym; ustawodawca zdecydował, że dopiero na takim etapie postępowania wyłączy możliwość samodzielnego podejmowania czynności procesowych przez strony. Podobnie w przypadku możliwości zakupu leków mamy do czynienia z podziałem na substancje, których zakup i przyjmowanie nie wymaga udziału lekarza w tym procesie.

²² Zarówno ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o advokaturze (Dz. U. z 2024 r. poz. 1564) jak i ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 499) w artykułach (odpowiednio) 4a i 8 nie przewidują możliwości prowadzenia działalności w formie spółek kapitałowych. Formy wykonywania zawodu mają na celu także zabezpieczanie interesu osób korzystających z psychoterapii.

„Psychoterapeuta wykonuje swoje usługi w formach (...)” nie jest terminologicznie spójny z art. 2 i innymi przepisami projektu.

Artykuł 9 projektu określa wymogi wobec osób wykonujących zawód zaufania publicznego psychoterapeuty. Punkt 1 wydaje się być zbędny, jako wyłączający z zawodu wyłącznie bezpaństwowców²³. Punkt 2 w tym artykule określa kierunki studiów, których ukończenie pozwalałoby wykonywać zawód psychoterapeuty. Wnioskodawcy zdecydowali się na bardzo szeroki katalog kierunków studiów, który może budzić wątpliwości z perspektywy ochrony praw osób korzystających z psychoterapii. Określenie wykształcenia za pomocą dziedzin, a nie dyscyplin czy kierunków studiów prowadzi do nadania uprawnień absolwentom wszystkich kierunków studiów mieszczących się w ramach wymienionych dziedzin. Będą to kierunki zdecydowanie odległe od psychoterapii, takie jak m.in. archeologia, historia sztuki, zagraniczne filologie, konserwacja dzieł sztuki i wiele innych. Uzasadnienie projektu jest przy tym niespójne z samymi jego założeniami. Wnioskodawcy zwracają uwagę, że wiele osób z wykształceniem teologicznym obecnie wykonuje zawód psychoterapeuty. Jest to argumentacja niespójna z samym projektem, który zmierza do ograniczenia możliwości wykonywania tego zawodu także osobom już go wykonującym, a nie dającym rękojmi wykonywania go w sposób odpowiedni (tj. zgodny ze stanem wiedzy w dyscyplinie i standardami wykonywania zawodu).

Należy się zgodzić z Wnioskodawcami, którzy w uzasadnieniu stwierdzili, że „Biorąc pod uwagę, że proponowana ustawa ma regulować nie tylko obszar związany z podmiotami leczniczymi, ale cały rynek psychoterapii, konieczna jest duża uważność w określaniu wykształcenia bazowego psychoterapeutów”²⁴. Określenie wymogu dotyczącego wykształcenia za pomocą dyscyplin, a nie dziedzin nauki, może mieć – jak się wydaje – negatywne skutki w tym kontekście.

Pod rozważę Wnioskodawców można poddać kwestię wprowadzenia do art. 9 projektu (określającego wymagania względem osoby wykonującej zawód psychoterapeuty) sformułowania „swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu”, obecnego w innych ustawach regulujących zawody zaufania publicznego²⁵ – aby osiągnąć skutek pewnej jednolitości w systemie prawnym regulacji dotyczących tych zawodów.

Przepisy art. 106 projektu regulują funkcjonowania „Sądu koleżeńskiego psychoterapeutów”. Zgodnie z art. 106 ust. 10 projektu „sędziów powołanych do orzekania w sprawie wyznacza prezes sądu koleżeńskiego w kolejności według wpływu sprawy, według listy sędziów (...)”. W ust. 13 i ust. 14 tego artykułu zawarto sformułowanie: „Odstąpienie od powołania sędziego do składu sądującego

²³ Można życzliwie założyć, że celem Wnioskodawców nie było wykluczenie bezpaństwowców z możliwości wykonywania zawodu psychoterapeuty.

²⁴ Projekt ustawy RPW/5317/2025, s. 109; [https://orka.sejm.gov.pl/Druki10ka.nsf/Projektv/10-RPW-5317-2025/\\$file/10-RPW-5317-2025.pdf](https://orka.sejm.gov.pl/Druki10ka.nsf/Projektv/10-RPW-5317-2025/$file/10-RPW-5317-2025.pdf).

²⁵ Przepisy takie znajdziemy w licznych ustawach, przykładowo można wyliczyć: art. 13 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2025 r. poz. 608); art. 13 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2023 r. poz. 1213); art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 339); art. 65 pkt 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2024 r. poz. 1564); art. 24 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 499).

dopuszczalne jest tylko z powodu choroby sędziego lub z innej ważnej przyczyny (...). Posłużenie się niekonkretnym sformułowaniem o „innej ważnej przyczynie” będzie skutkowało tym, że w wielu przypadkach powoływanie sędziów do orzekania będzie mogło nie następować w kolejności według wpływu sprawy. Może to prowadzić do osłabienia funkcjonowania reguły, która – jak można założyć – miała na celu przeciwdziałanie przydzielania konkretnych spraw konkretnym sędziom. Analogiczną uwagę należy sformułować w odniesieniu do art. 106 ust. 12 projektu.

W art. 176 ust. 5 projektu jest mowa o podejmowaniu decyzji przez Komitet Organizacyjny, ale brak uregulowania szczegółów (określenia, jaką większością głosów decyzja ma być podjęta) może prowadzić do wątpliwości interpretacyjnych w praktyce funkcjonowania tego podmiotu.

Projekt wymaga licznych korekt legislacyjnych. Przykładowo można wskazać na: brak fragmentu treści przepisu (art. 35 ust. 6 projektu), niespójności w treści (pomiędzy art. 76 ust. 1 a ust. 2 i 3 – wskazanie w różnych jednostkach redakcyjnych, że samorząd składa się z różnych organów), przepisy odsyłające do siebie nawzajem (art. 179 ust. 5 i 6 oraz art. 180 pkt 2 projektu), brak konsekwencji w nakreślaniu kręgu podmiotów objętych daną regulacją (w art. 175 ust. 1 projektu jest mowa o stowarzyszeniach psychoterapeutów, związkach tych stowarzyszeń oraz sekcjach naukowych psychoterapii, które stają się ośrodkami egzaminacyjnym w rozumieniu przepisów projektu, a tymczasem w art. 179 ust. 1 projektu jest mowa tylko o stowarzyszeniach, zaś w ust. 2 tego artykułu – o stowarzyszeniach i sekcjach, które uzyskały status ośrodków egzaminacyjnych, choć wydaje się, że we wszystkich tych regulacjach katalog podmiotów powinien być taki sam). Brak korekt w tym zakresie skutkowałby trudnościami w stosowaniu ustawy.

Projekt ustawy był przedmiotem analiz Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji (BEOS) Kancelarii Sejmu w zakresie zgodności z prawem Unii Europejskiej²⁶. W wydanej opinii stwierdzono, że projekt „w zakresie, w jakim nie umożliwia – w celu uzyskania wpisu do Rejestru Psychoterapeutów Aplikantów – uznania wykształcenia lub szkolenia zdobytego w innych niż Polska państwach członkowskich UE za równorzędne z wykształceniem lub szkoleniem uzyskanym w Polsce, jest niezgodny z art. 1, art. 4, art. 12 akapit pierwszy i art. 13 ust. 1 dyrektywy 2005/36/WE”. Natomiast w opinii dotyczącej projektu w wersji uwzględniającej autopoprawkę²⁷ stwierdzono, że projekt nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej²⁸.

Projekt był także przedmiotem opinii BEOS sporządzonej w trybie art. 95a ust. 3 regulaminu Sejmu²⁹. W opinii stwierdzono, że nie jest to projekt ustawy

²⁶ *Opinia w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o zawodzie psychoterapeuty oraz samorządzie zawodowym (przedstawiciel wnioskodawców: posłanka Marta Golbik)*, opinia BEOS z 25 II 2025 r., BEOS-WPEiM-257/25.

²⁷ Autopoprawka z 25 III 2025 r.

²⁸ *Opinia w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o zawodzie psychoterapeuty oraz samorządzie zawodowym w wersji uwzględniającej autopoprawkę (przedstawiciel wnioskodawców: posłanka Marta Golbik)*, opinia BEOS z 31 III 2025 r., BEOS-WPEiM-582/25.

²⁹ *Opinia w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o zawodzie psychoterapeuty oraz samorządzie zawodowym (przedstawiciel wnioskodawców: posłanka Marta Golbik) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu*, opinia BEOS z 25 II 2025 r., BEOS-WP/WPEiM-258/25.

wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu. Konkluzję tę powtórzono w analogicznej opinii dotyczącej projektu w wersji uwzględniającej autopoprawkę³⁰.

VI. Skutki społeczne projektowanej ustawy

A) Podmioty, na które wpływa projekt:

- osoby wykonujące zawód psychoterapeuty – ok. 22 tys.³¹,
- osoby wykonujące zawód psychoterapeuty, posiadające certyfikat lub tytuł specjalisty – ok. 6 tys.,
- osoby, które rozpoczęły szkolenie psychoterapeutyczne – ok. 16 tys.,
- osoby wykonujące zawód psychologa,
- osoby wykonujące zawód lekarza psychiatrii (5 322 osób³²),
- ośrodki szkolące w zawodzie psychoterapeuty,
- ośrodki stażowe dla psychoterapeutów,
- minister właściwy do spraw zdrowia,
- minister właściwy do spraw rodziny, pracy i polityki społecznej,
- Narodowy Fundusz Zdrowia,
- ogół społeczeństwa.

B) Wpływ na społeczeństwo

Na wstępie należy zauważyć, że przedkładany projekt nie jest efektem doświadczeń wynikających z obowiązywania art. 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, który obecnie szczątkowo definiuje psychoterapię i reguluje zasady udzielania usług psychoterapeutycznych, gdyż przepis ten wszedł dopiero w 2024 r. i jest zbyt wcześnie by oceniać jego funkcjonowanie. Wnioskodawcy w art. 186 ust. 2 uchylają art. 5 ust. 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, co dodatkowo komplikuje odbiór społeczny proponowanej ustawy, gdyż definicja psychoterapii pozostaje w ustawie psychiatrycznej, w projekcie (art. 2 ust. 1) jest definiowana inaczej, a zasady uzyskiwania prawa wykonywania zawodu psychoterapeuty przechodzą do nowej ustawy. Sytuację komplikują również przepisy przejściowe projektu (art. 173 ust. 2, art. 175), które odwołują się do uchylanego art. 5 ust. 3 ustawy psychiatrycznej. Mając doświadczenie z brakiem samorządu psychologów, mimo obowiązywania od 2006 r. ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów³³, należy dłożyć starań by przepisy nowej ustawy były kompleksowe w zakresie definiowania psychoterapii i zasad dopuszczania do

³⁰ *Opinia w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o zawodzie psychoterapeuty oraz samorządzie zawodowym w wersji uwzględniającej autopoprawkę (przedstawiciel wnioskodawców: posłanka Marta Golbik) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu*, opinia BEOS z 31 III 2025 r., BEOS-WPEiM-583/25.

³¹ Dane ilościowe zaczerpnięte z projektu ustawy.

³² W tym 4 754 psychiatrów ogólnych i 568 psychiatrów dzieci i młodzieży – *Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów wg dziedziny i stopnia specjalizacji*, https://nil.org.pl/uploaded/files/1741004816_zestawienie-nr-4-01032025.pdf, s. 3.

³³ Dz. U. z 2019 r. poz. 1026 ze zm.

wykonywania zawodu psychoterapeuty, co wpłynie pozytywnie zarówno na odbiorców świadczeń psychoterapeutycznych, jak i osoby już wykonujące ten zawód, a także na kształcących się lub zamierzających wybrać ten zawód. W przeciwnym razie nowa ustawa, zamiast porządkować sytuację na rynku tych usług, w odczuciu społecznym będzie bardziej go komplikowała.

Konsultacje społeczne projektu ustawy pokazały, że jest to regulacja bardzo kontrowersyjna i szeroko dyskutowana. W konsultacjach wypowiedziało się kilka tysięcy osób (7 574³⁴). Opinie o projekcie, jak zwykle przy tematyce budzącej duże zainteresowanie społeczne, były bardzo różne – od zdecydowanego poparcia dla projektu po uznanie zaprezentowanych rozwiązań za nietrafione i źle regulujące istniejące problemy w tym zakresie. Przy czym warto zwrócić uwagę, że te same regulacje dla jednych respondentów są zaletą, a dla innych wadą projektu.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu celem regulacji jest m.in. doprowadzenie do wzrostu jakości udzielanych świadczeń psychoterapeutycznych oraz wzrostu dostępności psychoterapii, szczególnie w ramach świadczeń udzielanych w podmiotach leczniczych. Wnioskodawcy podkreślają, że ograniczenie dostępu do zawodu psychoterapeuty może działać odwrotnie w stosunku do zakładanych celów. Warto zatem dość szczegółowo przeanalizować, jakie potencjalne skutki społeczne może wywołać ten poselski projekt (zarówno w uzasadnieniu, jak i w konsultacjach projektu wskazuje się, że jest to projekt stworzony przez grupę zainteresowanych środowisk naukowych i stowarzyszeń praktyków).

Dążenie do podniesienia jakości udzielanych świadczeń przez psychoterapeutów jest popierane zarówno przez środowiska psychoterapeutów, jak i odbiorców ich usług. Było to widoczne w trakcie konsultacji społecznych. Osoby wyrażające aprobatę dla projektu wskazywały, że jest on m.in. efektem „dwuletnich prac i szerokich konsultacji z 95% kluczowych towarzystw psychoterapeutycznych w kraju. Uwzględnia dorobek i tradycje szkół psychoterapii, jednocześnie zapewniając ochronę prawną zarówno terapeutom, jak i pacjentom. Szybkie przyjęcie ustawy jest kluczowe, zwłaszcza w obliczu dezinformacji w mediach społecznościowych oraz rosnącej liczby osób potrzebujących profesjonalnej pomocy psychologicznej”³⁵.

Aby podnieść jakość świadczeń, Wnioskodawcy proponują wprowadzenie ograniczeń w dostępie do zawodu psychoterapeuty. Zgodnie z art. 5 ust. 3 pkt 1 lit. a) – psychoterapię w ramach opieki zdrowotnej nad osobami z zaburzeniami psychicznymi prowadzi osoba posiadająca certyfikat psychoterapeuty, która m.in. posiada tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra albo spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. Zgodnie z art. 9 pkt 2 projektu, psychoterapeutą będzie mogła być osoba posiadająca tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych, sztuki, medycznych i nauk o zdrowiu, rodzinie oraz w dyscyplinie nauk teologicznych.

³⁴ Nie licząc tych osób, które – przez pomyłkę – komentarze do opiniowanej ustawy zamieściły w konsultacjach do innych projektów ustaw, a nie były to jednostkowe przypadki.

³⁵ ID ankiety: 22059.

Zważywszy, że uzyskanie certyfikatu uregulowane w art. 10 projektu zakłada 4-letnią specjalizację, a w zasadzie „naukę zawodu” psychoterapeuty, odejście od obecnych wymogów (posiadania wykształcenia wyższego magisterskiego) nie zostało przekonująco wyjaśnione w uzasadnieniu projektu. Warto jednak zwrócić uwagę, że istnieją także odmienne poglądy uznające przyjęte w projekcie rozwiązania w tym zakresie za zbyt liberalne.

Przepisy projektu dotyczące kształcenia w zawodzie psychoterapeuty mogą powodować szereg negatywnych skutków, w tym m.in.:

- ograniczenie liczby osób objętych kształceniem niezależnie od wzrostu zapotrzebowania społecznego,
- brak nadzoru (nad kształceniem) administracji rządowej odpowiedzialnej za zapewnienie kadry fachowej do świadczenia usług zdrowotnych,
- nieuzasadnione merytorycznie wydłużanie kształcenia w celu uzyskania prawa do wykonywania zawodu psychoterapeuty,
- usankcjonowanie ustawowe obecnych zasad kształcenia, które to zasady sami Wnioskodawcy uznają za mało efektywne i nieodpowiadające zapotrzebowaniu rynku.

Rozdział 4 projektu pt. Szkolenie psychoterapeutów aplikantów i psychoterapeutów oddaje szkolenie w ręce Krajowej Rady Psychoterapeutów, przy czym przepisy ustawowe pozostawiają w gestii tego ciała i komisji ekspertów wiele kluczowych decyzji warunkujących akredytację podmiotów do prowadzenia szkolenia (m. in. dotyczących kadry dydaktycznej, która daje rękojmię prowadzenia zajęć na wysokim poziomie merytorycznym i etycznym; programu szkolenia; systemu weryfikacji kandydatów do szkolenia). Może to powodować problemy interpretacyjne przy wydawaniu akredytacji tym bardziej, że mogą o nią występować – zgodnie z art. 38 projektu – bardzo różne organizacyjnie podmioty. Podmiot szkolący może wykonywać swoją działalność w formie: działalności gospodarczej, spółki cywilnej, spółki prawa handlowego, stowarzyszenia, fundacji, uczelni wyższej, instytutu badawczego.

Za złożenie wniosku o wpis do rejestru podmiotów szkolących Krajowa Rada Psychoterapeutów będzie pobierać opłatę, której wysokość sama określi. Wnioskodawcy nie zaproponowali ograniczenia wysokości opłaty za wpis. Można przyjąć, że takie regulacje ustawowe będą podnosić koszty szkolenia, zarówno po stronie podmiotów szkolących, jak i samych uczestników szkolenia. W efekcie koszty te będą przenoszone również na świadczeniobiorców usług psychoterapeutów, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Może to finalnie stworzyć barierę ekonomiczną w dostępie do tego typu świadczeń, szczególnie dotkliwie odczuwane w przypadku osób gorzej sytuowanych materialnie. Bariery ekonomiczne, które mogą wystąpić w tak skonstruowanym systemie dostępu do zawodu psychoterapeuty, będą miały także inny negatywny społecznie wymiar. Przy braku możliwości dostępu do świadczeń psychoterapeutów posiadających prawo wykonywania zawodu zgodnie z ustawą pojawią się na rynku świadczenia „zastępcze”, przystępniejsze cenowo, choć świadczone przez osoby niekoniecznie odpowiednio przygotowane merytorycznie. Spowoduje to, że niektóre cele projektu nie zostaną zrealizowane. Wydaje się, że w trakcie prac legislacyjnych

nad projektem należałoby tak zmienić przepisy dotyczące szkolenia w zawodzie, aby wskazane wyżej zagrożenia zminimalizować.

Podobne uwagi można formułować w stosunku do przepisów regulujących zasady tworzenia ośrodków stażowych i egzaminacyjnych. I w tym przypadku organem władczym ma być Krajowa Rada Psychoterapeutów. Tak daleko idące przekazanie uprawnień do szkolenia i egzaminowania przyszłych psychoterapeutów organom samorządu zawodowego może mieć negatywne skutki społeczne.

Projekt może generować napięcia między osobami wykonującymi zawód psychologa i zawód psychoterapeuty. Przyjęte w projekcie rozwiązania (uchylenie art. 4 ust. 1 pkt 4)³⁶ oraz wyrażone w uzasadnieniu projektu oceny stanu kształcenia psychologów³⁷ mogą prowadzić do braku współpracy między tymi środowiskami zawodowymi, co w naturalny sposób wpłynie negatywnie na sytuację osób potrzebujących wsparcia lub leczenia z powodu zaburzeń psychicznych. Jeśli ocena kształcenia psychologów jest prawdziwa, zamiast deprecjonować przygotowanie tej grupy do wykonywania zawodu należałoby podjąć kroki w celu sanacji w tym zakresie. Wyrażony w uzasadnieniu pogląd, że „nie ma żadnego wykształcenia bazowego, które dawałoby kompleksowe przygotowanie do podjęcia szkolenia w zakresie psychoterapii. (...) Z drugiej strony podstawowym narzędziem pracy psychoterapeuty jest osobowość, której studia nie weryfikują” podważa wiele przepisów projektu dotyczących zasad dostępu do szkolenia psychoterapeutów.

W przypadku zasad szkolenia i wymogów stawianych przyszłym psychoterapeutom opinie wyrażane w konsultacjach projektu były bardzo różne. Od akceptacji zaproponowanych rozwiązań i powierzenia kształcenia samorządowi zawodowemu po wskazywanie wad takich rozwiązań³⁸.

³⁶ Wykonywanie zawodu psychologa polega na świadczeniu usług psychologicznych, w szczególności na psychoterapii.

³⁷ W uzasadnieniu Wnioskodawcy negatywnie oceniają stan kształcenia na kierunku psychologia: „Na 140 uczelni, na których powstał kierunek psychologia, ponad 90 ma negatywną opinię Państwowej Komisji Akredytacyjnej i mimo tego dalej kształcą w zawodzie psychologa. Oznacza to, że w ciągu kilku lat tytuł magistra psychologii uzyskają tysiące osób bez przygotowania klinicznego.”

³⁸ „Projekt ustawy nie zapewnia należytego przygotowania do wykonywania zawodu psychoterapeuty. Otwarcie zawodu psychoterapeuty dla absolwentów tak szerokiego spektrum kierunku jest moim zdaniem błędem, gdyż uzupełnianie wiedzy, o którym mowa w projekcie ustawy nie jest należyte. Ponadto prowadzenie badań w obszarze psychoterapii, dydaktyka dotycząca psychoterapii, a nawet praca administracyjna czy pełnienie funkcji kierowniczych w jednostkach zajmujących się psychoterapią zdecydowanie niesłusznie w projekcie ustawy zrównane są wykonywaniem zawodu psychoterapeuty – te czynności wymagają odmiennych kompetencji. Ustawa nie gwarantuje, że osoby wykonujące zawód psychoterapeuty będą należycie przygotowane do wykonywania tego zawodu. Zamiast merytorycznego przygotowania zakłada konieczność posiadania <<predyspozycji osobowościowych>> – jakich konkretnie? kto i jak miałby je sprawdzać i na ich podstawie decydować o możliwości wykonywania przez daną osobę zawodu psychoterapeuty?” – ID ankiety: 22344.

„Ustawa spowoduje pogorszenie dostępu do profesjonalnej psychoterapii, przez z jednej strony wprowadzenie ujednolicenia szkoleń (łączenia metod z różnych nurtów, a nie wysokospecjalistycznego szkolenia modalnościowego jak obecnie) i zasad przyjmowania na szkolenia (obecnie ośrodki mogą samodzielnie definiować wąskie wymagania, np. przyjmować tylko psychologów i lekarzy, w przypadku ustawy samorządowej nie będą mogły różnicować dostępu do szkolenia ze względu na wykształcenie węższe niż w ustawie, co wynika z doktryny prawnej) oraz wymusi zmiany w systemie publicznym (gdzie obecnie NFZ stosuje listę 6 kierunków bazowych) przez dopuszczenie do pacjentów osób z PWZ mimo braku studiów kierunkowych, których nie zastąpi kilkadziesiąt godzin <<dokształcenia z psychologii>>. Ustawa spowoduje pogorszenie dostępu do profesjonalnego leczenia psychoterapeutycznego dla pacjentów oraz wprowadzi pogorszenie standardów szkolenia psychoterapeutów.” – ID ankiety: 20923.

Projekt w art. 5 ust. 2 reguluje najniższe wynagrodzenie psychoterapeuty wykonującego zawód w ramach podmiotu leczniczego. Jest to materia zupełnie innej ustawy i przyjęcie takich rozwiązań może skutkować roszczeniami innych zawodów medycznych regulowanych ustawowo do umieszczania w ich ustawach zawodowych przepisów o wynagrodzeniach, co może skutkować zwiększaniem presji płacowej w publicznej służbie zdrowia. Na przykładzie tych przepisów widać tendencję do reprezentowania partykularnego interesu tej grupy zawodowej co może przynieść negatywne skutki społeczne. Zwiększenie kosztów tego rodzaju świadczeń i ograniczenie ich liczby w systemie publicznym, co zamiast poprawić dostęp społeczeństwa do tych świadczeń ograniczy je, co byłoby sprzeczne z celami wskazywanymi przez Wnioskodawców.

Kontrowersyjne – z punktu widzenia interesu świadczeniobiorcy – jest ustawowe rozgraniczenie modeli teoretycznych oraz standardów zawodowych i etycznych (w art. 2 ust. 2 i przepisach dotyczących odpowiedzialności zawodowej). Przyjmując ustawę o zawodzie psychoterapeuty należałoby zapewnić, że osoby wykonujące ten zawód będą miały ogólną wiedzę o wszystkich modelach teoretycznych i stosowane przez nie metody będą odpowiednie, a nie tylko będą mieściły się w wybranym podejściu. Dla ochrony interesu pacjentów należałoby prawnie wyodrębnić każdy model teoretyczny i zasady kształcenia i odpowiedzialności zawodowej.

VII. Skutki gospodarcze projektowanej ustawy

Analizowana regulacja wprowadzająca ustawę o zawodzie psychoterapeuty w Polsce ma charakter kompleksowy, gdyż de facto obejmuje swym zakresem cały rynek usług psychoterapeutycznych i najważniejsze instytucje tworzące samorząd zawodowy³⁹. Choć może się wydawać, że kwestie związane ze zdrowiem psychicznym, regulacją zawodu psychoterapeuty, zakresem wykonywanych przez nich czynności oraz funkcjonowaniem samorządu zawodowego mają głównie wymiar społeczny i dotyczą przede wszystkim sektora ochrony zdrowia, to podstawowe jej elementy mogą być oceniane również przy wykorzystaniu rezultatów badań ekonomicznych, zwłaszcza tych dotyczących regulacji zawodów.

Podaż specjalistów, dostępność usług, ceny, jakość świadczonych usług oraz poziom zaufania konsumentów – wszystkie te aspekty mogą być analizowane w oparciu o dorobek badań ekonomicznych dotyczący wpływu interwencji państwa w konkretny wycinek rynku pracy. Każdy z tych elementów można badać zarówno z perspektywy skutków krótkoterminowych, jak i długoterminowych, uwzględniając zachodzące na rynku dynamiczne zmiany sytuacji⁴⁰.

³⁹ W konsultacjach społecznych nad proponowaną regulacją wzięła udział duża liczba osób, co świadczy o zainteresowaniu tematem i jego wpływie na określoną sferę życia społecznego. Opinie uczestników w zakresie skutków gospodarczych były zróżnicowane, a niekiedy przeciwstawne, co podkreśla wielowymiarowy charakter ocenianych zmian. Wysoka liczba zaangażowanych osób wskazuje, że regulacja dotyczy istotnych kwestii, natomiast szerokie spektrum stanowisk odzwierciedla różnorodność perspektyw i możliwych skutków wprowadzenia nowych przepisów.

⁴⁰ Każda tak kompleksowa regulacja wywołuje daleko idące skutki, które ze względu na złożoność uwarunkowań społeczno-gospodarczych mają charakter probabilistyczny. Niniejsza analiza koncentruje

Koszty gospodarcze zaburzeń psychicznych w UE (łącznie 27 państw) są znaczące i możliwe do precyzyjnego oszacowania, przekraczając 4% PKB (ponad 600 mld euro) rocznie. Wśród nich należy wyróżnić⁴¹:

- koszty bezpośrednie (około 170 mld euro), obejmujące wydatki na leczenie oraz programy opieki zdrowotnej;
- koszty pośrednie związane ze stratami w produktywności (około 260 mld euro), wynikające z obniżonego poziomu zatrudnienia oraz efektywności pracy osób zmagających się z zaburzeniami psychicznymi;
- wydatki na programy zabezpieczenia społecznego, które sięgają około 170 mld euro.

Jeszcze większe są koszty utraconych lat życia spowodowanych chorobami psychicznymi i ich skutkami, szacowane na 6-7,7% PKB w państwach europejskich⁴². Ponadto, w związku z faktem, że popyt na usługi związane z ochroną zdrowia psychicznego jest wysoki (1 na 5 dorosłych w UE doświadcza w ciągu życia łagodniejszych lub umiarkowanych problemów psychicznych)⁴³, a w związku ze zmianami kulturowymi takimi jak brak stygmatyzacji czy z większą świadomością społeczną będzie rósł, bez wątpienia zapotrzebowanie na usługi psychoterapeutyczne ma wymiar powszechny. Dane sprzed pandemii COVID-19 dla Polski pokazują, że koszty leczenia chorób psychicznych w Polsce wynosiły ok. 3% PKB tj. ok. 13 mld euro rocznie (w tym koszty systemu zdrowotnego 5,1 mld euro, koszty opieki socjalnej 3,2 mld euro, koszty pośrednie wynikające z utraty produktywności – 4,6 mld euro)⁴⁴.

Do 2030 roku zaburzenia zdrowia psychicznego mogą stać się istotną barierą dla rozwoju gospodarczego. Oznacza to, że inwestycje w skuteczniejszą profilaktykę, wczesne wykrywanie oraz leczenie zaburzeń psychicznych mogą przynieść znaczące korzyści gospodarcze. Problemy zdrowia psychicznego nie są więc jedynie kwestią indywidualnego dobrostanu – mają one kluczowe znaczenie dla funkcjonowania rynku pracy, systemu opieki zdrowotnej i stabilności finansów publicznych⁴⁵.

się na identyfikacji możliwych konsekwencji ekonomicznych związanych z wprowadzeniem omawianych przepisów, uwzględniając również te efekty, których prawdopodobieństwo wystąpienia jest niskie. Oceniając skutki regulacji, trzeba uwzględniać i zaakceptować niepewność, zwłaszcza przy analizie tak złożonych obszarów jak rynek usług psychoterapeutycznych.

⁴¹ J. Simon, P. Boyer, J.M. Caldas-de-Almeida, M. Knapp, P. McCrone, P. Gorwood, W. Oertel, C. Arango, J. Treasure, A.H. Young, F. Destrebecq, V. Quoidbach, *Viewpoint: Assessing the value of mental health treatments in Europe*, "European Psychiatry", vol. 66, no. 1, e59, 2023.

⁴² Tamże.

⁴³ *The economic impact of mental disorders in Europe: the importance of prevention in workplaces and schools*, <https://www.angelinipharma.com/our-responsibility/headway-a-new-roadmap-in-mental-health/the-economic-impact-of-mental-disorders-in-europe-the-importance-of-prevention-in-workplaces-and-schools/>(<https://www.angelinipharma.com/our-responsibility/headway-a-new-roadmap-in-mental-health/the-economic-impact-of-mental-disorders-in-europe-the-importance-of-prevention-in-workplaces-and-schools/>).

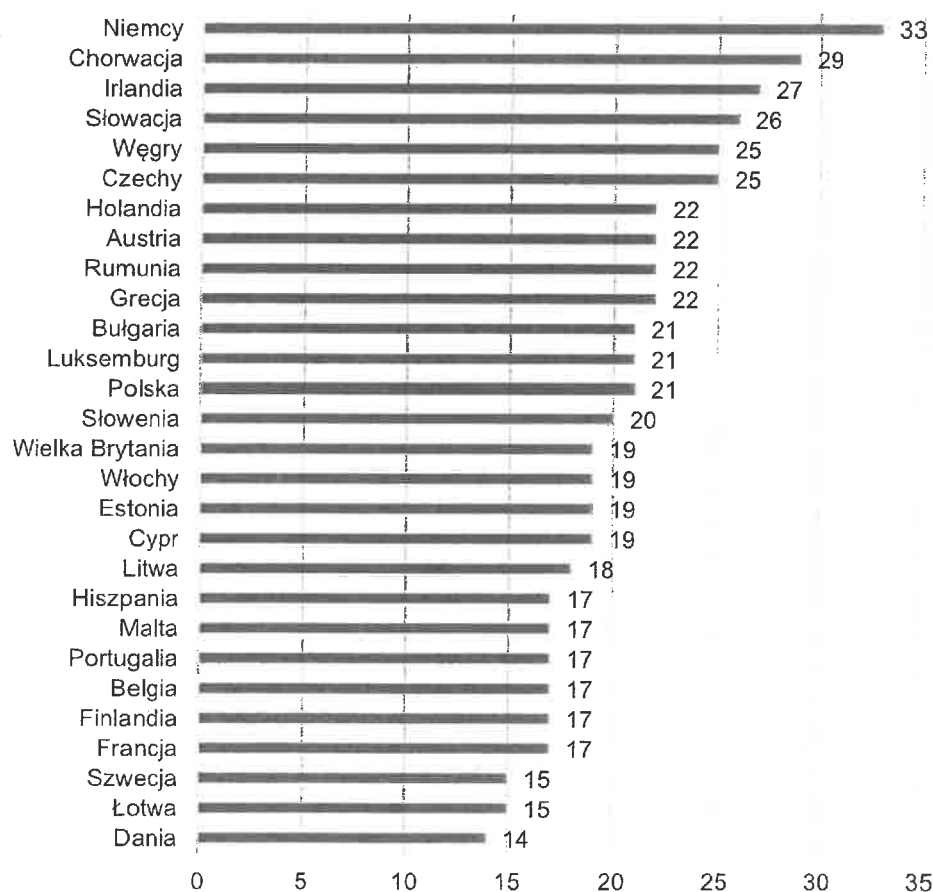
⁴⁴ *Zdrowie psychiczne w Unii Europejskiej*, Opracowania Tematyczne, OT-674, Kancelaria Senatu, Warszawa 2019, https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/175/plik/ot-674_zdrowie_psychiczne.pdf.

⁴⁵ J. Simon i in., op. cit.

Problematyka regulowania zawodów

Analizowane skutki gospodarcze wprowadzenia regulacji zawodu psychoterapeuty należy umieścić w szerszym kontekście globalnych trendów regulacyjnych. Regulacja rynku pracy i poszczególnych zawodów⁴⁶, rozumiana jako proces, w którym władze publiczne określają kwalifikacje konieczne do wykonywania określonego zawodu, odgrywa istotną rolę zarówno w Unii Europejskiej, jak i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem Stanów Zjednoczonych. W wielu państwach UE, jak i w USA, obserwujemy rosnącą tendencję do wprowadzania coraz bardziej szczegółowych regulacji zawodowych (mowa tutaj o wszystkich zawodach – poczynając od na przykład elektryków na lekarzach kończąc)⁴⁷.

Wykres 1. Udział licencjonowanych zawodów w całkowitej sile roboczej w wybranych państwach UE (w %)



⁴⁶ Regulacje te mogą mieć charakter obowiązkowy, gdy spełnianie określonych kwalifikacji jest wymagane przez prawo, bądź dobrowolny, kiedy jest to pozostawione do decyzji poszczególnych grup profesjonalistów. Charakterystyczne są dwa główne modele: ochrona tytułu, w której jedynie osoby spełniające określone kryteria mogą posługiwać się konkretnym tytułem zawodowym, oraz ochrona zadań, w ramach której prawo wykonywania niektórych czynności zawodowych ograniczone jest do osób posiadających odpowiednie licencje.

⁴⁷ Np. od lat 50. XX wieku regulacje zawodowe w USA znacząco się nasiliły. Podczas gdy w latach 50. jedynie około 5% pracowników posiadało licencję zawodową, do 2015 roku odsetek ten wzrósł do 25%. Najnowsze dane z 2025 roku wskazują, że 24% zatrudnionych Amerykanów posiada certyfikat lub licencję, z czego 21,6% ma licencję zawodową. To pokazuje, jak w ciągu dekad regulacje obejmujące rynek pracy stawały się coraz bardziej powszechne, wpływając zarówno na dostęp do zawodów, jak i na warunki zatrudnienia. <https://www.bls.gov/cps/cpsaat53.htm>.

Źródło: M. M. Kleiner, *The Influence of Occupational Licensing and Regulation*, IZA World of Labor, 2017.

Powyższy wykres pokazuje, że przypadki regulacji zawodów wcale nie są odosobnione, a wręcz przeciwnie – zawody regulowane stanowią duży odsetek rynków pracy w UE. W ciągu kilku ostatnich dekad tendencje regulacyjne wzrosły, również w Polsce, choć można także zidentyfikować okresy, w których przeważają działania deregulacyjne.

Wpływ na jakość usług i zaufanie

Jedną z głównych motywacji stojących za decyzją o regulacji konkretnego zawodu jest przekonanie, że aktualny stan faktyczny – czyli jakość usług na rynku nieuregulowanym – jest niski⁴⁸ lub w najlepszym razie mieszany⁴⁹. Regulowanie ma ograniczyć asymetrię informacji między dostawcami usług a konsumentami i zwiększyć zaufanie konsumentów do usługodawców. Asymetria informacji występuje wtedy, gdy jedna strona relacji (np. konsument) ma znacznie mniej wiedzy na temat jakości usługi niż druga strona (np. usługodawca). Jest to szczególnie istotne w zawodach, w których trudno samodzielnie ocenić kompetencje specjalistów, jak w przypadku lekarzy, prawników czy właśnie psychoterapeutów. Przyjmuje się więc, że osoby szukające konkretnej usługi mogą mieć trudności w ocenie, kto faktycznie oferuje usługi najwyższej jakości, wynikające z doświadczenia zawodowego i odpowiedniego wykształcenia. W efekcie regulacja zawodowa ma na celu stworzenie mechanizmów zapewniających minimalny poziom kompetencji specjalistów (tzw. sygnał kompetencji), co teoretycznie powinno prowadzić do poprawy jakości usług i większego zaufania konsumentów⁵⁰. Chodzi zarówno o zabezpieczenie interesu publicznego, jak i podniesienie standardów wykształcenia oraz kompetencji osób wchodzących do zawodu⁵¹.

Jednakże, jak wskazują zagregowane wyniki badań, statystyczny wpływ regulacji na wzrost jakości bywa trudny do wyizolowania i raczej niewielki lub żaden⁵². Choć są i takie badania, które w indywidualnych przypadkach pokazują, że

⁴⁸ W konsultacjach społecznych pojawiały się głosy podkreślające konieczność wyeliminowania z rynku psychoterapeutów, którzy nie spełniają wymagań stawianych osobom, które chcą wykonywać ten zawód (ID ankiety: 6184, 9433).

⁴⁹ Regulacje mogą podnieść jakość usług, jednocześnie ograniczając dostęp do zawodu wyłącznie dla wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Jednak mogą również obniżyć jakość poprzez ograniczenie konkurencji, podniesienie cen oraz wypychanie części usług do szarej strefy lub działań typu 'zrób to sam. za: P. McLaughlin, M.D. Mitchell, A. Philpot, *The Effects of Occupational Licensure on Competition, Consumers, and the Workforce*, Mercatus Center, 2017, <https://www.mercatus.org/research/public-interest-comments/effects-occupational-licensure-competition-consumers-and>.

⁵⁰ Licencjonowanie ma na celu zapewnienie jakości poprzez eliminację niekompetentnych osób lub oszustów" za: *Occupational Licensing in Health Care*, „Health Economics”, <https://health.iresearchnet.com/health-economics/medical-workforce/occupational-licensing-in-health-care/>.

⁵¹ W podobnym tonie wypowiadali się osoby biorące udział w konsultacjach społecznych analizowanej regulacji (ID ankiety: 97700, 113593, 99273, 10001).

⁵² M. Dillender, A.T. Lo Sasso, B.J. Phelan, M.R. Richards, *Occupational Licensing and the Healthcare Labor Market*, “National Bureau of Economic Research”, Working Paper No. 29665, 2022.; Dan King, *New Study: Occupational Licenses Do Not Increase Quality of Service*, 2020, <https://ij.org/press-release/new-study-occupational-licenses-do-not-increase-quality-of-service/>; P. McLaughlin, M.D. Mitchell, A. Philpot, *The Effects of Occupational Licensure on Competition, Consumers, and the Workforce*, Mercatus Center, 2017, <https://www.mercatus.org/research/public-interest-comments/effects-occupational-licensure-competition-consumers-and>.

może ona przynieść korzyści – jak sugerują przykłady z zakresu opieki nad dziećmi, pracy nauczycieli oraz położnych⁵³. Z kolei w innym obszarze zawodów medycznych nie obserwuje się znaczącej poprawy stanu zdrowia pacjentów (np. w przypadku usług dentystycznych)⁵⁴. Sugeruje się, że tego typu regulacje działają w tym przypadku raczej jako sygnał kompetencji (wskazują na pewien poziom kwalifikacji lub umiejętności) niż faktyczny mechanizm podnoszenia standardów usług⁵⁵. Niemniej w zawodach o dużej asymetrii informacji może odgrywać istotną rolę w ochronie konsumentów przed niską jakością i potencjalnymi nadużyciami. W konsekwencji może wzrosnąć zaufanie do psychoterapii jako formy leczenia, co może zwiększać popyt na te usługi⁵⁶.

Podsumowując, badania dotyczące wpływu regulowania zawodów na jakość usług pozostają niejednoznaczne, ale w przypadku zawodów z obszaru usług szeroko rozumianej ochrony zdrowia mogą poprzez swoją funkcję sygnalizowania kompetencji zwiększać bezpieczeństwo osób korzystających z psychoterapii⁵⁷.

Wpływ na liczbę osób wykonujących zawody regulowane

Badania dotyczące średniego wpływu regulacji dużej grupy zawodów wskazują, że regulacje mogą ograniczać liczbę praktykujących specjalistów, czego efektem jest spadek podaży nawet o 17–27%⁵⁸ i wolniejsza dynamika wzrostu w danej branży⁵⁹. Dotyczy to zarówno niezależnych praktyków, jak i firm potrzebujących wykwalifikowanych pracowników, np. kancelarii prawnych czy biur

⁵³ V. Hotz, M. Xiao, *The Impact of Regulations on the Supply and Quality of Care in Child Care Markets*, "American Economic Review", vol. 101/5, 2011, s. 1775-1805; D. Anderson, *The Effect of Occupational Licensing on Consumer Welfare: Early Midwifery laws and Maternal Mortality*, NBER Working Paper 22456; B. Larsen, *The Effect of Occupational Licensing Stringency on the Teacher Quality Distribution*, NBER Working Paper 28158.

⁵⁴ M. Kleiner, R. Kudrle, *Does Regulation Affect Economic Outcomes? The Case of Dentistry*, "The Journal of Law and Economics", vol. 43/2, 2000, s. 547-582.

⁵⁵ Pomiar zmian jakości po uregulowaniu zawodów napotyka liczne trudności, ponieważ regulacje zazwyczaj koncentrują się na wymaganiach formalnych, takich jak wykształcenie i certyfikaty, zamiast na rzeczywistych efektach pracy. Jakość usług jest często subiektywna i trudna do uchwycenia w badaniach empirycznych, zwłaszcza w zawodach, gdzie konsumenci mają ograniczoną możliwość oceny kompetencji specjalistów. Stosowane wskaźniki, jak poziom wykształcenia czy samoocena klientów, nie zawsze odzwierciedlają rzeczywistą jakość. Dodatkowo w sektorach o asymetrii informacji, takich jak opieka zdrowotna, nawet po skorzystaniu z usługi pacjenci mogą mieć trudności w ocenie jej jakości. W efekcie badania nie dostarczają jednoznacznych dowodów, że licencjonowanie prowadzi do wyższej jakości usług.

⁵⁶ Aby więc decyzje regulacyjne były uzasadnione, kluczowe jest najpierw ustalenie faktycznego istnienia niedoskonałości rynku (np. niski poziom usług, możliwe szkody wyrządzane konsumentom, brak motywacji do podnoszenia jakości usług, asymetria informacji) i określenie, czy wprowadzenie licencji bądź innych ograniczeń rzeczywiście rozwiąże zidentyfikowane problemy i podniesie jakość usług. Dopiero wówczas można oczekiwać, że planowane interwencje przyniosą wymierne rezultaty za: *Competition and Regulation in Professions and Occupations*, OECD, 2024, https://www.oecd.org/en/publications/competition-and-regulation-in-professions-and-occupations_218869f5-en.html, s. 17.

⁵⁷ „Najważniejsze jednak, że konsumenci często nie wiedzą, czy dany zawód faktycznie podlega regulacjom ani jak trudno jest uzyskać licencję, co w konsekwencji ogranicza postrzeganie samej licencji jako wyraźnego sygnału jakości” za *Competition ...*, OECD, op. cit., s. 18.

⁵⁸ P.Q. Blair, B. W. Chung, *How Much of Barrier to Entry is Occupational Licensing?*, "British Journal of Industrial Relations", vol. 57, nr 4, 2019, s. 919–943.

⁵⁹ M. M. Kleiner, *Licensing Occupations: Ensuring Quality or Restricting Competition?*, Kalamazoo, MI: W.E. Upjohn Institute for Employment Research, 2006.

rachunkowych⁶⁰. Choć wprowadzenie łagodniejszych wymagań lub np. jednocześnie rozszerzenie zakresu zadań możliwych do wykonania przez osoby bez np. certyfikatów może nieco zwiększyć liczbę dostępnych usługodawców, restrykcyjne wymogi licencyjne w większości przypadków powodują istotne bariery wejścia, zmniejszając konkurencję i osłabiając dynamikę rynku.⁶¹ Ponadto, wysokie bariery wejścia do zawodu, takie jak długotrwałe i kosztowne procesy rekrutacyjne, mogą zniechęcać nowych specjalistów do rozpoczęcia działalności w tym sektorze.

W krótkim horyzoncie czasowym należy więc spodziewać się możliwego zmniejszenia podaży specjalistów i wolniejszego tempa rekrutacji nowych. Z drugiej strony doświadczenia państw takich Austria czy Szwecja pokazują, że długoterminowo stworzenie odpowiednich podstaw prawnych wykonywania zawodu psychoterapeuty może powodować stopniowe i powolne zwiększanie się liczby praktykujących psychoterapeutów. Mowa tutaj o horyzoncie co najmniej dziesięciu lat i więcej. Z drugiej strony brak regulacji może powodować, że liczba praktykujących psychoterapeutów będzie wysoka, ale przynajmniej część z nich nie będzie odpowiednio przygotowana do wykonywania zawodu (np. sytuacja psychoterapii w Wielkiej Brytanii)⁶².

Podsumowując, regulacje dotyczące zawodów specjalistycznych mogą ograniczać liczbę praktyków, zwłaszcza na początku ich wprowadzania, ale w dłuższej perspektywie mogą stopniowo przyczyniać się do powolnego wzrostu liczby wykwalifikowanych specjalistów.

Jeśli chodzi o wpływ na ceny i wynagrodzenia, to badania wskazują, że w zawodach objętych licencjonowaniem dochodzi do premii płacowych w porównaniu z profesjami nieregulowanymi. W USA wynoszą one ok. 14%⁶³, a w UE ok. 4%⁶⁴, choć na ostateczny wynik wpływa zarówno specyfika samych zawodów, jak i elementy systemu licencyjnego (np. zakres wymagań czy weryfikacje okresowe). Ponadto wysokość takich premii może się znacznie różnić między poszczególnymi profesjami. Część badaczy wskazuje, że przyczyną są nie tylko wyższe kwalifikacje sygnalizowane przez licencję, lecz także monopolizacja dostępu do zawodu, co prowadzi do możliwości „przechwytywania” dodatkowych zysków⁶⁵. Wprowadzenie obowiązkowej licencji na wykonywanie zawodu psychoterapeuty może prowadzić również do wzrostu kosztów usług z kilku powodów⁶⁶. Badania wskazują również, że regulacje licencyjne podnoszą ceny usług o 3-13%⁶⁷. Im bardziej rygorystyczne

⁶⁰ Kwestie związane z obawą o pogorszenie dostępności psychoterapeutów pojawiały się w trakcie konsultacji społecznych (ID ankiety: 113973, 58516, 11738, 534).

⁶¹ *Competition ...*, OECD, s. 19.

⁶² M. Možina, *Psychotherapy Regulation in European countries: Towards Psychotherapy as an Autonomous Profession and Scientific Discipline*, „Psychotherapie-Wissenschaft”, vol. 14, nr 2, 2024, s. 93–100.

⁶³ M.M. Kleiner, A.B. Krueger, *Analyzing the Extent and Influence of Occupational Licensing on the Labor Market*, „Journal of Labor Economics”, vol. 31, 2013, s. 173–202.

⁶⁴ M. Koumenta, M. Pagliero, *Occupational Regulation in the European Union: Coverage and Wage Effects*, „British Journal of Industrial Relations”, vol. 57, nr 4, 2018, s. 818–849.

⁶⁵ Tamże.

⁶⁶ Na efekt wzrostu cen psychoterapii zwracano uwagę w trakcie konsultacji społecznych (ID ankiety: 58518, 108189, 115451, 58212, 108546).

⁶⁷ E.J. Timmons, *Occupational Licensing*, „The Library of Economics and Liberty”, <https://www.econlib.org/library/enc/occupationallicensing.html>.

wymogi, tym większy wzrost kosztów. Wyższe ceny wynikają niekiedy z ograniczenia podaży specjalistów, a nie z oczekiwanego podniesienia jakości usług. Ograniczenie liczby uprawnionych terapeutów zmniejsza konkurencję, co może prowadzić do wzrostu cen, bez jednoznacznych dowodów na poprawę jakości⁶⁸.

Wzrost cen i marż, obserwowany w branżach z bardziej restrykcyjnymi regulacjami, jest spójny z danymi dotyczącymi wynagrodzeń. Istnieją przykłady, gdzie zaostrzenie wymogów skutkowało wzrostem cen usług nawet o 3-16%⁶⁹, natomiast liberalizacja – przynajmniej w niektórych analizowanych przypadkach – nie wiązała się z podwyżkami i mogła przyczynić się do obniżenia kosztów dla konsumentów⁷⁰. W efekcie silniejsze regulacje prowadzą często do ograniczenia konkurencji i w konsekwencji do wyższych cen, co potwierdzają także obserwacje wyższych marż w zawodach o bardziej restrykcyjnych wymogach⁷¹.

Z powodu spodziewanego spadku dostępności konsultacji psychoterapeutycznych (lub wolniejszego przyrostu liczby psychoterapeutów) przy jednoczesnym stałym lub rosnącym popycie na terapię, zgodnie z podstawowymi zasadami ekonomii, należy oczekiwać wzrostu cen tych usług oraz wzrostu wynagrodzeń psychoterapeutów. Taka sytuacja może poprawić sytuację materialną obecnych specjalistów i uczynić zawód psychoterapeuty bardziej atrakcyjnym dla przyszłych adeptów.

Z drugiej strony, spodziewane wyższe ceny usług mogą stanowić barierę szczególnie dla osób o niższych dochodach. Na przykład, badania wskazują, że licencjonowanie w sektorze opieki nad dziećmi prowadzi do wzrostu kosztów i zmniejszenia liczby dostawców na biedniejszych obszarach, jednocześnie poprawiając jakość usług w dzielnicach bogatszych, co de facto powoduje transfer korzyści od uboższych do zamożniejszych grup społecznych⁷². Choć oczywiście nie można zakładać, że taki efekt pojawi się w przypadku ocenianego projektu, to kwestię nierówności geograficznych i ekonomicznych również należy mieć na uwadze.

Podsumowując, regulowanie zawodów niesie ze sobą konsekwencje o charakterze ekonomicznym. Badania wskazują, że bariery wejścia na rynek pracy (np. kierunkowe wykształcenie, szkolenia, supervizja) początkowo zmniejszają liczbę profesjonalistów, co prowadzi do mniejszej konkurencji i ogranicza pulę dostępnych pracowników. Z drugiej strony takie rozwiązania pomagają eliminować z rynku ludzi, którzy nie dysponują odpowiednią wiedzą i kompetencjami do prowadzenia np. praktyki psychoterapeutycznej. Licencjonowanie wiąże się także z wyższymi wynagrodzeniami w zawodach regulowanych oraz podnosi prestiż zawodu. Regulacje zawodowe mają również szerokie konsekwencje wpływając na konsumentów i ogólną dostępność usług. Wyższe ceny oraz ograniczona liczba dostawców usług nie obciążają wszystkich grup społecznych w równym stopniu – to

⁶⁸ Tamże.

⁶⁹ M. Kleiner, R. Kudrle, op. cit.

⁷⁰ E. Athanassiou et al., *The Effects of Liberalization of Professional Requirements in Greece*, Centre of Planning and Economic Research (KEPE), 2015; M. Rojek, M. Masior, *The Effects of Reforms Liberalising Professional Requirements in Poland*, "Report for the European Commission, 2016.

⁷¹ *Competition ...*, OECD, s. 22.

⁷² *Competition ...*, OECD, s. 23.

konsumenci o niższych dochodach są bardziej narażeni na pogorszenie dostępu do usług. Ponadto wysokie koszty i ścisłe wymogi licencyjne mogą sprzyjać osobom z uprzywilejowanych środowisk, ograniczając awans społeczny mniej zamożnym kandydatom do zawodu. Wpływ regulacji zawodu psychoterapeuty nie musi automatycznie prowadzić do wzrostu jakości usług, stanowi raczej sygnał kompetencji wskazujący, że osoby posługujące się tytułem zawodowym psychoterapeuty ukończyły odpowiednie kształcenie. Poprawa jakości zależy od rzeczywistego funkcjonowania rynku usług psychoterapeutycznych, skuteczności mechanizmów doskonalenia zawodowego oraz sprawności eliminacji nadużyć w ramach systemu nadzoru.

VIII. Skutki projektowanej ustawy dla sektora finansów publicznych

Projektowana ustawa może wywoływać skutki finansowe dla sektora finansów publicznych. Skutki mogą dotyczyć w szczególności budżetu państwa, zwłaszcza pod stronie wydatkowej.

Wnioskodawcy przedstawili szczegółowe wyliczenia dotyczące 3 pierwszych lat po wejściu w życie przedmiotowej ustawy. Zakładając zatem, iż projekt zostanie przyjęty w 2025 r., jako pierwszy okres wystąpienia skutków finansowych należy przyjąć 2026 r. Założenie to jest o tyle istotne, gdyż w pierwszym roku funkcjonowania proponowanych przepisów Wnioskodawcy zakładają najwyższe wydatki z budżetu państwa, mające zostać poniesione w ramach części budżetu, której dysponentem jest minister właściwy do spraw rodziny, pracy i polityki społecznej. Oznacza to również, iż proponowane wydatki w tzw. okresie przygotowawczym (pierwszy rok) powinny zostać ujęte w projekcie budżetu państwa opracowywanym w bieżącym roku.

Okres przygotowawczy, czyli pierwszy rok od uchwalenia ustawy do jej wejścia w życie (okres vacatio legis) miałby objąć zadania dotyczące:

- utworzenia Komitetu organizacyjnego samorządu zawodowego psychoterapeutów, w tym rozpoczęcie działalności Prezydium oraz czterech tymczasowych izb regionalnych, a także ośmiu komisji ekspertów,
- stworzenie rejestru psychoterapeutów w formie systemu elektronicznego,
- przeprowadzenie pierwszych wyborów oraz pierwszych zjazdów samorządu na szczeblu krajowym i regionalnym.

Do przedłożonych wyliczeń dotyczących realizacji powyższych zadań w pierwszym roku Wnioskodawcy przyjęli następujące założenia ilościowe:

- ok. 22 tys. – liczba osób wykonujących zawód psychoterapeuty, którzy zostaną włączeni do samorządu zawodowego psychoterapeutów w pierwszym okresie,
- 1 758 290 zł – kwota wydatków z budżetu państwa konieczna do poniesienia w okresie przygotowawczym,
- 49 – liczba osób wchodzących w skład Komitetu organizacyjnego, którym mają przysługiwać wynagrodzenia (etaty), w tym 5 osób w Prezydium,

4 osoby w tymczasowych izbach regionalnych oraz po 5 osób w ramach 8 komisji, a także członkowie Komitetu przygotowujący podstawy formalne działalności,

- 702,6 tys. zł – łączna kwota wynagrodzeń w ujęciu rocznym (za 12 miesięcy) dla Komitetu organizacyjnego, w tym ekspertów komisji, przy założeniu wynagrodzenia w wysokości 3 117 zł (1/4 etatu na miesiąc) dla członków Prezydium oraz tymczasowych izb regionalnych, a także stawki godzinowej w wysokości 150 zł dla pozostałych członków Komitetu,
- 376,4 tys. zł – łączna kwota wynajmu i wyposażenia lokali oraz obsługi biurowej, prawnej i księgowej, w tym 102,4 tys. zł na wynagrodzenia dla pracowników biurowych,
- 400 tys. zł – jednorazowy koszt utworzenia i wdrożenia rejestru oraz innej obsługi informatycznej,
- 268 tys. zł – koszt przeprowadzenia wyborów oraz pierwszych zjazdów, przy założeniu ok. 500 zł na jednego delegata.

W projekcie nie wskazano źródeł ani podstawy wyliczenia powyżej przyjętych kwot i stawek jednostkowych. W pierwszym roku Wnioskodawcy nie zakładają wpływów z tytułu składki członkowskiej na rzecz samorządu zawodowego oraz opłaty za wpis do rejestru psychoterapeutów. Należy także dodać, iż mimo braku przewidywań Wnioskodawców co do wygenerowania wpływów, skutkiem finansowym planowanych do poniesienia proponowanych kwot wydatków z tytułu wynagrodzeń w łącznej kwocie ponad 800 tys. zł mogą być dochody podatkowe budżetu państwa oraz składki płacone na rzecz innych podmiotów publicznych (w tym ZUS i NFZ).

Proponowane założenia w ramach drugiego roku finansowania (prawdopodobnie 2027 r.), odpowiadającego pierwszemu okresowi obowiązywania ustawy, według Wnioskodawcy będą obejmowały 6 miesięcy w ramach ukonstytuowania się organów samorządu, organizacji izb oraz pionu odpowiedzialnego za postępowanie dyscyplinarne. W tym okresie wydatki finansowe z budżetu państwa zaplanowane na poziomie 573,8 tys. zł miałyby objąć:

- finansowanie wynajmu lokali,
- koszty pracownicze obsługi biurowej,
- szkolenia i opracowanie materiałów do szkoleń,
- zakup oprogramowania do obsługi postępowań dyscyplinarnych.

Ponadto Wnioskodawcy przewidują, iż Skarb Państwa corocznie będzie ponosił wydatki z tytułu kosztów czynności wykonywanych przez izby psychoterapeutów, których poziom obecnie jest trudny do wyliczenia i ma podlegać corocznym negocjacjom w zakresie „wyceny” wartości i liczby zadań. Koszty te mają objąć przede wszystkim zadania związane z prowadzeniem rejestrów oraz z działalnością regionalnych sądów koleżeńskich i Krajowego Sądu Koleżeńkiego. Założenie to Wnioskodawcy oparli na rozwiązaniu stosowanym już w zakresie rozliczania kosztów pomiędzy Ministerstwem Zdrowia i izbami lekarskimi.

Wnioskodawcy przewidzieli również konieczność przekazania zadań w zakresie nadzoru oraz rozliczenia środków dotacji w ramach powyższych

wydatków, co oznacza dodatkowe koszty pracownicze w proponowanej wysokości 47,4 tys. zł (1/4 etatu plus wyposażenie stanowiska).

W związku z powyższym, zgodnie z założeniem Wnioskodawców, od trzeciego roku od uchwalenia przedmiotowej ustawy, stałe coroczne koszty finansowania z budżetu państwa mają objąć:

- corocznie negocjowane wydatki z tytułu kosztów czynności wykonywanych przez izby psychoterapeutów,
- koszty rozliczeń i nadzoru – wynagrodzenie pracownicze w ministerstwie (około 37,4 tys. zł plus waloryzacja).

Od tego okresu zatem pozostałe koszty działalności samorządu zawodowego psychoterapeutów i izb powinny być sfinansowane ze wskazanych źródeł, w tym:

- środków ze składek członkowskich, których jednostkowa opłata planowana roczna jest w wysokości 250 zł,
- opłat pobieranych od podmiotów szkolących,
- innych opłat oraz kar,
- środków z działalności gospodarczej oraz z innych źródeł jak dotacje, subwencje, darowizny i spadki.

Wnioskodawcy szacują zatem, iż minimalna kwota finansowania jaka zostanie przeznaczona na działalność samorządu zawodowego, w tym izb – wyliczona w oparciu o założenia rocznej składki – może wynieść co roku 5,5 mln zł. Wpływy te mają pokryć głównie działalność administracyjną samorządu, w tym wynagrodzenia członków jego organów.

Warto jednak zwrócić uwagę, iż Wnioskodawcy przewidują także, iż dodatkowym źródłem finansowania samorządu zawodowego psychoterapeutów będą opłaty za wpis do rejestru. Roczną wartość tych opłat trudno jest obecnie wyliczyć, gdyż w założeniu Wnioskodawców jej wysokość określi samorząd.

Należy zatem wskazać, iż rozwiązanie to można odnieść do podobnej propozycji zawartej w rządowym projekcie ustawy o zawodzie psychologa oraz samorządzie zawodowym psychologów (druk nr 1344)⁷³. W OSR do tego projektu założono, iż opłata za wpis do spisu do czasu powołania samorządu wyniesie 50 zł oraz będzie stanowiła dochód budżetu państwa. Uwzględniając zatem powyższe założenie można oszacować, iż wpływy z tego tytułu w rozpatrywanej ustawie mogą wynieść:

- 0 zł – w pierwszym tzw. roku przygotowawczym,
- 1,1 mln zł – w drugim roku, przy założeniu, iż do rejestru wpisze się ok. 22 tys. psychoterapeutów i zapłaci 50 zł za jednorazowy wpis,
- średnio 30 tys. zł rocznie – z tytułu wpisów kolejnych psychoterapeutów do rejestru.

Uwzględniając szacunki zawarte w poniższej tabeli w perspektywie 10 lat można wskazać, iż w przypadku wariantu 1 (bez opłat wpłacanych do budżetu państwa zgodnie z założeniem Wnioskodawcy) w każdym roku wydatki budżetu państwa mogą się zwiększać, co oznacza ujemne saldo budżetu z tytułu skutków

73

<https://orka.sejm.gov.pl/Druki10ka.nsf/0/9C8F4435249CA521C1258CA5003A8E63/%24File/1344.pdf>.

finansowych projektu. Ryzyko to może również być związane z zakładaną „negocjowaną” formułą dotacji. Z kolei wariant drugi z opłatami umożliwi częściowe zrekompensowanie w szczególności wydatków poniesionych przez budżet państwa w pierwszym roku przygotowawczym (1,1 mln zł z dochodów z opłat w drugim roku wobec 1,7 mln zł wydatków poniesionych przez Skarb Państwa w pierwszym roku). Z tego tytułu wariant drugi powinien również podlegać rozważeniu przy rozpatrywaniu projektu.

w mln zł											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	SUMA
Dochody											
Wariant 1 (bez opłat)	0,2	0,2	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,56
Wariant 2 (z opłatami)	0,2	1,3	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	1,9
Wydatki											
	1,7	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	3,1
Saldo											
Wariant 1 (bez opłat)	-1,5	-0,4	- 0,08	- 0,08	- 0,08	- 0,08	- 0,08	- 0,08	- 0,08	- 0,08	- 2,54
Wariant 2 (z opłatami)	-1,5	0,7	- 0,05	- 0,05	- 0,05	- 0,05	- 0,05	- 0,05	- 0,05	- 0,05	-1,2

Wyjaśnienie: Dochody

Wariant 1 – uwzględnione szacunki z tytułu wpływów podatkowych od planowanych wynagrodzeń

Wariant 2 – wpływy podatkowe plus wpływy z tytułu opłat za wpis do rejestru

Reasumując należy wskazać, iż przedmiotowy projekt prawdopodobnie będzie wywoływał skutki finansowe dla sektora finansów publicznych zarówno po stronie dochodów, ale w szczególności wydatków budżetu państwa w proponowanej części, które dysponentem jest minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Budżet państwa najwyższe wydatki poniesie w pierwszym tzw. przygotowawczym roku. Wnioskodawcy zakładają, iż w kolejnych latach samorząd zawodowy psychoterapeutów nadal będzie finansowany z budżetu państwa, jednak większa część działalności miałaby zostać pokryta z wpływów z rocznych składek członkowskich i innych źródeł. Wysokość szacunkowa wartości tych składek powinna być wystarczająca do pokrycia planowanych kosztów działalności samorządu i izb. W związku z powyższym możliwe wydaje się rozważenie wariantu przekierowania opłat za wpis do rejestru do budżetu państwa analogicznie jak w proponowanym rządowym projekcie ustawy dotyczącym samorządu zawodowego psychologów, co może zrekompensować początkowe wydatki budżetowe i obniżyć możliwe coroczne ujemne salda z tytułu realizacji przepisów przedmiotowej ustawy.

W trakcie przeprowadzonych konsultacji społecznych nie wskazano istotnych informacji dotyczących skutków finansowych projektowanych przepisów dla sektora finansów publicznych.

IX. Inne skutki projektowanej ustawy

Nie zidentyfikowano innych skutków wejścia w życie projektowanej ustawy.

X. Zmiana obciążeń administracyjnych

Projekt wprowadza do porządku prawnego szereg nowych regulacji charakterystycznych dla powołania samorządu zawodowego, które przewidują konieczność spełniania licznych warunków administracyjnych zarówno dla członków samorządu zawodowego, w tym także należących do władz samorządowych, jak i ministra właściwego do spraw rodziny, pracy i polityki społecznej.

Ponadto, obciążenia regulacyjne związane z wejściem w życie ustawy o zawodzie psychoterapeuty obejmują przede wszystkim konieczność spełnienia restrykcyjnych wymogów formalnych i administracyjnych przez obecnych i przyszłych specjalistów a także nowe obowiązki administracyjne (wpis do rejestru, opłacenie składek, spełnianie określonych standardów etycznych i szkoleniowych), co będzie generowało dodatkowe koszty administracyjne (np. organizacyjne, czasowe). Po stronie przedsiębiorców prowadzących placówki psychoterapeutyczne regulacja może generować dodatkowe wymogi związane z koniecznością dostosowania procedur do nowych standardów.

Projekt może wywoływać także dodatkowe obciążenia administracyjne, w szczególności dotyczące nadzoru nad działalnością samorządu zawodowego psychoterapeutów, rozliczaniem środków przekazywanych na pokrycie kosztów czynności wykonywanych przez izby.

XI. Konkluzje

1. Skutki prawne: Ogólnym skutkiem wprowadzenia projektu do porządku prawnego będzie określenie zasad i warunków wykonywania zawodu psychoterapeuty jako zawodu zaufania publicznego oraz ustanowienie samorządu zawodowego psychoterapeutów, wraz z określeniem zasad jego organizacji i działania. Stworzone zostaną prawne podstawy do zapewnienia nadzoru nad wykonywaniem zawodu psychoterapeuty. Jednak warunkiem efektywnego osiągnięcia tych rezultatów jest dokonanie szeregu korekt legislacyjnych w projektowanych regulacjach, których niewprowadzenie skutkowałoby trudnościami w stosowaniu przyszłej ustawy.

2. Skutki społeczne: Zawarte w projekcie ustawy regulacje nie tworzą spójnych podstaw do budowy całościowego modelu opieki nad osobami mającymi problemy ze zdrowiem psychicznym. Zaproponowane zmiany są wyrazem dążenia środowiska do ustawowego zagwarantowania sobie ochrony prawnej wykonywania zawodu, co nie zawsze jest korzystne dla społeczeństwa. W przyjętych rozwiązaniach samorząd zawodowy ma przejąć całkowitą kontrolę nad kształceniem, egzaminowaniem i dopuszczaniem do zawodu psychoterapeuty. Brak jest w tym procesie miejsca dla ministra właściwego do spraw zdrowia, który na podstawie innych ustaw jest zobowiązany do organizacji opieki zdrowotnej (szczególnie tej finansowanej ze środków publicznych), w tym zapewnienia kadr. Projekt nie reguluje zasad współpracy/relacji psychoterapeutów z psychologami

i lekarzami psychiatrami, co może mieć negatywne skutki dla osób wymagających kompleksowego leczenia w tym zakresie.

3. Skutki gospodarcze: Wprowadzenie regulacji zawodu psychoterapeuty poprzez ustanowienie jednolitych standardów może przyczynić się do wzrostu zaufania konsumentów do usług psychoterapeutycznych (sygnał kompetencji) i wyeliminowania z rynku osób o niskich kwalifikacjach. Regulacja zmniejszy ryzyko, że osoby bez przygotowania będą świadczyć usługi psychoterapeutyczne. Istnieją jednak wątpliwości co do faktycznej poprawy jakości usług, ponieważ wyniki dotychczasowych badań w zakresie zawodów regulowanych nie dają gwarancji, że same regulacje zawodów podnoszą jakość usług świadczonych przez specjalistów wykonujących takie zawody. W krótkiej i średniookresowej perspektywie czasowej zaostrzenie regulacji i wymagań zawodowych ograniczy podaż specjalistów, prowadząc tym samym do wzrostu cen usług oraz utrudnień w dostępności dla konsumentów, szczególnie mniej zamożnych i mieszkających poza dużymi aglomeracjami. W długim okresie możliwy jest wzrost liczby wykwalifikowanych psychoterapeutów poprzez podniesienie prestiżu i atrakcyjności tej ścieżki zawodowej oraz wzrost ich wynagrodzeń. Jednakże utrzymywanie się barier wejścia na rynek dla nowych specjalistów będzie sprzyjało powstawaniu lub pogłębianiu nierówności – zarówno geograficznych (większa koncentracja specjalistów w zamożniejszych regionach), jak i społeczno-ekonomicznych (lepszy dostęp do usług dla grup o wyższych dochodach).

4. Skutki finansowe: Rozpatrywany projekt będzie wywoływał skutki finansowe dla sektora finansów publicznych, w tym w szczególności dla budżetu państwa po stronie wydatków. Najwyższe obciążenie finansowe w kwocie 1,7 mln zł ma dotyczyć pierwszego roku realizacji ustawy w okresie przygotowawczym. Zgodnie z założeniami Wnioskodawców od trzeciego roku po uchwaleniu projektu działalność samorządu zawodowego psychoterapeutów powinna być pokryta m.in. ze składek członkowskich. Ponadto część zadań izb ma być nadal finansowana z dotacji budżetowej z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W przypadku opłat za wpis do rejestru możliwe są dwa warianty rozwiązań do rozważenia.

5. Rozwiązania zagraniczne: W oparciu o przepisy poszczególnych państw europejskich oraz analizy EAP można wyróżnić trzy kategorie regulacji dotyczących zawodu psychoterapeuty. Do pierwszej należą kraje uznające psychoterapię za niezależny zawód: Austria, Chorwacja, Malta i Niemcy. W państwach tych funkcjonują kompleksowe systemy edukacyjne, egzaminy zawodowe oraz oficjalne rejestry psychoterapeutów. Druga kategoria obejmuje państwa, w których istnieją regulacje dotyczące zawodu psychoterapeuty, jednak warunkiem jego wykonywania lub możliwości kształcenia w tym zakresie jest posiadanie wykształcenia medycznego lub psychologicznego – m.in. Dania, Finlandia, Francja, Holandia, Luksemburg, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Włochy. Trzecia kategoria to państwa, w których zawód psychoterapeuty nie jest uregulowany, a tytuł zawodowy nie jest prawnie chroniony (np. Albania, Cypr, Grecja, Litwa, Portugalia, Serbia). W

części z tych państw środowisko psychoterapeutyczne wprowadziło mechanizmy samoregulacji lub dobrowolnej rejestracji zawodowej. EAP wskazuje jednak na ogólnoeuropejski trend zmierzający do formalizacji i standaryzacji tego zawodu.

Autorzy:

Bartosz Pawłowski, ekspert ds. legislacji (pkt I-III)

Kaja Krawczyk, specjalista w Wydziale Oceny Skutków Regulacji (pkt IV, XI.5)

Marcin Wróbel, specjalista ds. społecznych, Paweł Kościelny, ekspert ds. legislacji (pkt V, X, XI.1)

Grzegorz Ciura, specjalista ds. społecznych (pkt. VI, X, XI.2)

dr Radosław Zyzik, specjalista ds. systemu gospodarczego (pkt. VII, X, XI.3)

dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, specjalista ds. finansów publicznych (pkt. VIII, X, XI.4)

Akceptował:

Wicedyrektor Biura Ekspertyz
i Oceny Skutków Regulacji

Ziemowit Cieślik

/podpisano elektronicznie/